DRAF PEDOMAN

Pedoman Model CBC Berkelanjutan

Draf Lengkap

Strategi keberlanjutan operasional dan finansial bagi Community-Based Clinic (CBC) yang memberikan layanan HIV dan layanan berbasis komunitas

Paket terpadu Pedoman · Modul Pelatihan · E-learning



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Yayasan Spiritia

Draf versi 0.5 · November 2026

Daftar Isi

Ringkasan untuk Pengelola Program 4

Bab 1 Pendahuluan 5
- 1.1 Latar Belakang 5
- 1.2 Tujuan 6
- 1.3 Sasaran Pengguna 6
- 1.4 Ruang Lingkup 7
- 1.5 Dasar Hukum 7
- 1.6 Prinsip 8
- 1.7 Cara Menggunakan Pedoman 8

Bab 2 Memahami CBC, Keberlanjutan, dan Tipologi Klinik 10
- 2.1 Apa Itu CBC 10
- 2.2 Posisi CBC dalam Sistem Kesehatan 11
- 2.3 Paket Layanan CBC 12
- 2.4 Keberlanjutan Operasional dan Finansial 12
- 2.5 Tingkat Kesiapan 14
- 2.6 Empat Tipe CBC 14
- 2.7 Menilai Kesiapan Klinik Sendiri 15

Bab 3 Mendirikan CBC 17
- 3.1 Menilai Kebutuhan dan Kelayakan 17
- 3.2 Memilih Bentuk Badan Hukum Pemilik 17
- 3.3 Memilih Jenis Klinik 18
- 3.4 Langkah Perizinan 19
- 3.5 Kewajiban Setelah Izin Terbit 20
- 3.6 Merancang Layanan Ramah Komunitas Sejak Awal 20

Bab 4 Tata Kelola, SDM, dan Sistem Operasional 22
- 4.1 Tata Kelola dan Kepemimpinan 22
- 4.2 Perencanaan Strategis dan Rencana Bisnis 22
- 4.3 Sumber Daya Manusia 23
- 4.4 Sistem Informasi dan Pemantauan 24
- 4.5 Logistik dan Rantai Pasok 24
- 4.6 Kemitraan dan Jejaring 25
- 4.7 Manajemen Keuangan Dasar dan Pengendalian Internal 25

Bab 5 Memetakan Biaya dan Pendapatan 26
- 5.1 Mengapa Menghitung Biaya Penting 26
- 5.2 Jenis Biaya 26
- 5.3 Menghitung Biaya per Layanan 27
- 5.4 Memetakan Pendapatan 28
- 5.5 Arus Kas, Cadangan, dan Titik Impas 28
- 5.6 Laporan Keuangan yang Memisahkan Sumber Dana 29

Bab 6 Memilih Kombinasi Pembiayaan 30
- 6.1 Prinsip Memilih Sumber Dana 30
- 6.2 Peta Sumber Pembiayaan 30
- 6.3 Menyusun Kombinasi per Tipe Klinik 32
- 6.4 Mencegah Pembiayaan Ganda 32
- 6.5 Pengalaman CBC 33

Bab 7 Kredensialing JKN dan Kontrak Pemerintah 34
- 7.1 Menjadi FKTP Mitra BPJS Kesehatan 34
- 7.2 Memaksimalkan Pendapatan JKN 35
- 7.3 Swakelola Tipe III 36
- 7.4 Hibah Daerah dan Mekanisme Lain 37
- 7.5 Advokasi Anggaran 37

Bab 8 Menjaga Akses, Mutu, Kerahasiaan, dan Peran Komunitas 39

8.1 Nilai CBC yang Harus Dijaga 39
8.2 Enam Guardrail Akses 39
8.3 Kerahasiaan dan Pelindungan Data 40
8.4 Peran Komunitas Selama Transisi 41
8.5 Mengomunikasikan Perubahan kepada Pengguna 41
8.6 Bila Fungsi Dialihkan ke Puskesmas 41

Bab 9 Transformasi dan Rencana Transisi Klinik 43
9.1 Memahami Linimasa Transisi 43
9.2 Memetakan Fungsi yang Bergantung pada Donor 44
9.3 Memilih Jalur Transformasi 45
9.4 Menyusun Skenario dan Proyeksi 36 Bulan 45
9.5 Menyusun Rencana Transisi 46
9.6 Manajemen Risiko Transisi 47

Bab 10 Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran 48
10.1 Indikator Keberlanjutan 48
10.2 Siklus Tinjauan 49
10.3 Peran Pengelola Program 49
10.4 Berbagi Pembelajaran Antar-CBC 49

Lampiran 1 Alat Swa-Nilai Kesiapan Keberlanjutan CBC 50

Lampiran 2 Lembar Penentuan Tipe Klinik 53

Lampiran 3 Daftar Periksa Perizinan Klinik Pratama 54

Lampiran 4 Templat Studi Kelayakan Sederhana 55

Lampiran 5 Daftar Periksa Kapasitas Organisasi 56

Lampiran 6 Templat Rencana Retensi Staf Kunci 58

Lampiran 7 Lembar Kerja Costing per Layanan 59

Lampiran 8 Petunjuk Simulator Keberlanjutan CBC 60

Lampiran 9 Matriks Pemilihan Sumber Pembiayaan 61

Lampiran 10 Templat Proposal ke CSR atau Filantropi 62

Lampiran 11 Daftar Periksa Kredensialing BPJS Kesehatan 63

Lampiran 12 Daftar Periksa Swakelola Tipe III dan Kalender Anggaran 64

Lampiran 13 Templat Kerangka Acuan Kerja Swakelola 65

Lampiran 14 Matriks Guardrail Akses dan Tarif 66

Lampiran 15 Contoh Pesan Komunikasi Perubahan 67

Lampiran 16 Kerangka Pemantauan Berbasis Komunitas 68

Lampiran 17 Templat Rencana Transisi Klinik 69

Lampiran 18 Lembar Klasifikasi Fungsi yang Bergantung pada Donor 71

Lampiran 19 Contoh Rencana Transisi (Klinik Fiktif) 72

Lampiran 20 Dasbor Indikator Keberlanjutan 73

Lampiran 21 Ringkasan Profil Anonim CBC A–G 74

Daftar Istilah 75

Daftar Pustaka 78

Ringkasan untuk Pengelola Program

Halaman ini merangkum pedoman bagi pengelola program di Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.

Pesan utama

- **Waktunya mendesak.** Dukungan Global Fund untuk HIV di Indonesia dijadwalkan berakhir setelah Grant Cycle 9 (2032). Kredensialing JKN, perubahan izin, dan siklus anggaran daerah masing-masing membutuhkan waktu berbulan-bulan sampai lebih dari setahun.
- **CBC kuat dalam operasional harian, tetapi rapuh dalam jembatan ke dana publik.** Dari tujuh CBC yang didukung Kementerian Kesehatan melalui pembiayaan Global Fund, hanya satu yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hampir separuh responden menerima honor dari program donor.
- **Dana publik adalah tulang punggung keberlanjutan.** Sumber yang dimaksud adalah kapitasi JKN bagi klinik pratama, APBD melalui SPM pelayanan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV, dan kontrak swakelola tipe III untuk layanan komunitas. Tarif hanya pelengkap dan harus tunduk pada guardrail akses.
- **Setiap klinik berbeda.** Pedoman memakai empat tipe klinik untuk menentukan jalur tindakan: terhubung dana publik, mapan tetapi belum terhubung, rentan finansial, dan belum berizin mandiri.
- **Akses tidak boleh menjadi korban.** Enam guardrail akses berlaku untuk setiap pilihan pembiayaan, dan komunitas berperan memantau kepatuhannya.

Dukungan yang paling menentukan dari pengelola program

Pengelola	Dukungan	Bab
Kementerian Kesehatan	Kejelasan posisi CBC dalam kebijakan dan peta jalan transisi; kesinambungan komoditas program; dorongan kontrak sosial bagi layanan komunitas	1, 2, 9, 10
Dinas Kesehatan	Pendampingan perizinan dan perubahan jenis klinik; memasukkan layanan CBC ke rencana kerja dan SPM; kontrak swakelola tipe III	3, 7, 9
BPJS Kesehatan	Kejelasan kredensialing bagi klinik pratama yang melayani populasi kunci; perlindungan data diagnosis HIV	7, 8
Yayasan Spiritia dan jaringan komunitas	Pendampingan teknis costing dan rencana transisi; forum belajar antar-CBC; pemantauan berbasis komunitas	5, 9, 10

Bab 1 Pendahuluan

Pokok bab ini

- Mengapa keberlanjutan CBC perlu direncanakan sekarang
- Tujuan, sasaran pengguna, dan ruang lingkup pedoman
- Dasar hukum dan prinsip yang berlaku untuk semua pilihan pembiayaan
- Cara memakai pedoman sesuai tahap dan tipe klinik Anda

1.1 Latar Belakang

Situasi epidemi dan target nasional

Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 564.000 orang dengan HIV (ODHIV) pada 2025. Capaian tiga indikator 95-95-95 masing-masing baru 63% (mengetahui status), 67% (mendapat pengobatan ARV), dan 55% (virus tersupresi). Sebanyak 76% kasus terkonsentrasi di 11 provinsi prioritas, dan populasi kunci menanggung beban terbesar [1]. Pemerintah menetapkan target eliminasi HIV, AIDS, dan infeksi menular seksual (IMS) pada akhir 2030, termasuk capaian 95-95-95 dan penurunan infeksi baru sebesar 90% dibandingkan 2010 [2].

Kesenjangan terbesar ada di awal kaskade: menemukan orang yang belum mengetahui statusnya dan mempertahankan mereka dalam pengobatan. Banyak anggota populasi kunci enggan datang ke fasilitas kesehatan karena takut stigma, khawatir soal kerahasiaan, atau terbentur jam layanan. Di titik inilah Community-Based Clinic (CBC) berperan. Klinik yang dikelola oleh atau bersama komunitas ini menggabungkan layanan klinis dengan pendampingan sebaya, penjangkauan, dan jam layanan yang menyesuaikan kebutuhan pengguna.

Contoh dari lapangan

Dalam self-assessment Oktober 2026, pengelola tujuh CBC menyebut tiga hal yang membuat klinik mereka dipilih komunitas: jam layanan sampai sore dan malam hari bagi pengguna yang bekerja siang, layanan yang ramah dan cepat, serta pendampingan sebaya. Satu klinik mendampingi lebih dari 1.600 ODHIV yang sedang menjalani ARV, dan klinik lain sekitar 440 ODHIV. Bagi mereka, berhentinya klinik berarti terputusnya pengobatan.

Lanskap pendanaan yang berubah

Sejak 2025, bantuan kesehatan eksternal turun tajam dan diproyeksikan 30–40% lebih rendah pada 2025 dibandingkan 2023 [3]. Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah atas. Dukungan Global Fund untuk HIV dan TB di Indonesia berada pada kelompok alokasi final Grant Cycle 9 (periode alokasi 2029–2031), sedangkan malaria pada Grant Cycle 8 [4]. Global Fund menyatakan dukungan untuk HIV dan TB dijadwalkan berakhir setelah GC9 pada 2032. Sampai saat itu, dukungan untuk komoditas esensial dan layanan berbasis komunitas tetap berjalan [5].

Sejak Maret 2026, Kementerian Kesehatan secara resmi memimpin proses transisi dengan peta jalan berjangka waktu untuk mengalihkan pembiayaan, mekanisme pembelian layanan, dan model kontrak ke sistem domestik. Pendekatannya memisahkan kegiatan yang dapat segera dibiayai penuh dari anggaran domestik dari kegiatan yang memerlukan tahapan atau pembiayaan campuran [5]. Kajian bersama program HIV nasional tahun 2026 juga merekomendasikan perencanaan pembiayaan di seluruh kaskade layanan serta model layanan dan pembiayaan yang disesuaikan dengan wilayah [6].

Bagi CBC, perubahan ini berarti fungsi yang saat ini dibiayai donor harus menemukan sumber pembiayaan domestik sebelum dukungan berakhir. Fungsi itu antara lain honor tenaga kesehatan dan pendamping sebaya, penjangkauan, sebagian biaya operasional, dan sistem pencatatan.

Hasil self-assessment menunjukkan besarnya tantangan ini. Hampir separuh responden (11 dari 23) menerima honor dari program Global Fund, hanya satu dari tujuh klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan pemahaman tentang syarat menerima dana publik masih rendah.

Arah kebijakan global

Strategi AIDS Global 2026–2031, yang diadopsi Dewan Koordinasi Program UNAIDS pada Desember 2025 [7], mendorong peralihan dari respons yang digerakkan donor ke respons yang dipimpin negara. Strategi ini meminta layanan HIV diintegrasikan ke layanan kesehatan primer dan paket manfaat jaminan kesehatan semesta, layanan yang dipimpin komunitas dimasukkan ke mekanisme kontrak sosial, pendamping sebaya diformalkan dengan honor dan pelindungan, serta biaya pengguna untuk layanan esensial dihapus [3]. WHO menganjurkan prioritisasi layanan secara bertahap, integrasi ke layanan primer, dan transisi pembiayaan yang selaras dengan sistem keuangan publik [8]. Pedoman konsolidasi WHO tentang penyelenggaraan layanan HIV (2026) menegaskan layanan yang berpusat pada orang, terintegrasi, dan setara [9].

> **Mengapa harus mulai sekarang**
>
> - **Waktu yang tersisa terbatas.** Sekitar enam tahun sebelum dukungan Global Fund untuk HIV berakhir, dan sebagian dukungan dapat berkurang lebih awal.
> - **Dana publik bergerak lambat.** Usulan ke APBD harus masuk siklus perencanaan daerah sekitar satu tahun sebelum anggaran berjalan.
> - **Kredensialing dan perizinan butuh waktu.** Mengubah bentuk izin dan menjadi mitra BPJS Kesehatan memerlukan persiapan berbulan-bulan.
> - **Komunitas perlu disiapkan.** Perubahan cara pembiayaan perlu dikomunikasikan agar pengguna tidak berhenti datang.

1.2 Tujuan

Tujuan umum

Menjadi acuan bagi pengelola CBC dalam mendirikan, menjalankan, dan mentransformasi klinik agar layanan HIV dan layanan komunitas tetap berjalan secara operasional dan finansial, tanpa mengorbankan akses bagi populasi kunci dan ODHIV.

Tujuan khusus

Setelah memakai pedoman ini, pengelola CBC mampu:

1. menilai tingkat kesiapan dan menentukan tipe kliniknya;
2. memenuhi persyaratan perizinan dan standar yang membuka akses ke dana publik;
3. memperkuat tata kelola, sumber daya manusia, sistem informasi, dan logistik;
4. menghitung biaya per layanan, memetakan pendapatan, dan memproyeksikan arus kas;
5. menyusun kombinasi pembiayaan yang berkelanjutan sesuai tipe klinik;
6. mengurus kredensialing JKN dan kontrak dengan pemerintah daerah;
7. menjaga akses, mutu, dan kerahasiaan serta peran komunitas selama transisi; dan
8. menyusun, menjalankan, dan memantau rencana transisi klinik.

1.3 Sasaran Pengguna

Pengguna	Yang dibutuhkan dari pedoman	Bab paling relevan
Pengguna utama		

Pengguna	Yang dibutuhkan dari pedoman	Bab paling relevan
Pengurus organisasi berbasis komunitas (OBK) atau LSM pemilik klinik	Arah strategis, pilihan bentuk badan hukum dan izin, kemitraan dengan pemerintah	2, 3, 6, 9
Manajer atau penanggung jawab klinik	Langkah operasional: costing, kredensialing, kontrak, rencana transisi	2, 4, 5, 7, 9
Bagian keuangan dan administrasi	Pencatatan per sumber dana, biaya per layanan, arus kas, klaim	5, 6, 7
Tenaga kesehatan dan pendamping sebaya	Menjaga mutu, kerahasiaan, dan akses; peran dalam transisi	4, 8
Pengguna pendukung		
Kementerian Kesehatan	Gambaran kebutuhan CBC untuk kebijakan, kontrak, dan pembiayaan transisi	1, 2, 9, 10
Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota	Dasar perizinan, kontrak swakelola, integrasi ke perencanaan daerah	3, 7, 9, 10

1.4 Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup tiga tahap kehidupan klinik dengan bobot yang seimbang, dan memberi perhatian khusus pada transisi dari dukungan donor:

Tahap	Situasi klinik	Isi utama
Mendirikan	Komunitas atau organisasi berencana membuka CBC, atau layanan komunitas yang belum berizin akan menjadi klinik	Kelayakan, badan hukum, jenis klinik, perizinan, desain layanan ramah komunitas
Menjalankan	CBC sudah beroperasi dan ingin memperkuat fondasi	Tata kelola, SDM, sistem informasi, logistik, costing, diversifikasi pendapatan
Transformasi	CBC menghadapi berkurangnya dukungan donor atau perlu mengubah model	Klasifikasi fungsi, jalur transformasi, kredensialing JKN, kontrak pemerintah, rencana transisi

Layanan yang dicakup adalah layanan klinis sesuai standar dan peraturan (tes HIV, pengobatan ARV, PrEP, IMS, TB-HIV, hepatitis, kesehatan jiwa, dan layanan pengurangan dampak buruk) serta layanan non-klinis berbasis komunitas (penjangkauan, pendampingan, dukungan sebaya, dan pencegahan).

Batasan. Pedoman ini tidak menggantikan pedoman nasional tata laksana klinis HIV, IMS, TB, atau hepatitis. Pedoman ini berfokus pada bagaimana klinik dikelola dan dibiayai agar layanan tersebut dapat terus diberikan.

1.5 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi [10];
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan [11];
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan [12];
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 [13];
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 [14];

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual [2];
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis [15]; dan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit [16].

> **Catatan status regulasi**
>
> Daftar ini disusun per 1 November 2026. Beberapa peraturan pelaksana sedang berubah, termasuk standar perizinan klinik, standar tarif JKN, dan ketentuan kredensialing. Peraturan teknis yang terkait langsung dengan langkah tertentu dicantumkan di bab yang membahasnya (Bab 3 dan Bab 7). Pengguna dianjurkan memeriksa versi terbaru di JDIH Kementerian Kesehatan sebelum mengajukan izin atau kontrak.

1.6 Prinsip

Tujuh prinsip berikut berlaku untuk semua keputusan yang diambil berdasarkan pedoman ini, termasuk pilihan sumber pembiayaan.

Prinsip	Artinya bagi CBC
1. Tidak meninggalkan siapa pun (Leave No One Behind)	Setiap perubahan model atau pembiayaan diuji dampaknya terhadap kelompok yang paling sulit dijangkau: waria, penasun, pekerja seks, LSL muda, ODHIV tanpa JKN, dan pengguna dari daerah terpencil.
2. Keterlibatan bermakna komunitas (GIPA/MIPA)	ODHIV dan populasi kunci terlibat dalam tata kelola, perencanaan, pemberian layanan, dan pemantauan klinik, bukan hanya sebagai penerima layanan.
3. Hak asasi dan nondiskriminasi	Layanan diberikan tanpa stigma dan diskriminasi atas dasar status HIV, orientasi seksual, identitas gender, pekerjaan, atau penggunaan napza.
4. Kerahasiaan	Data diagnosis dan identitas pengguna dilindungi dalam rekam medis, klaim JKN, pelaporan, dan kerja sama dengan pihak mana pun [2,10,15].
5. Akses dijaga di atas target pendapatan	Keberlanjutan finansial tidak boleh dicapai dengan menutup akses. Guardrail akses di Bab 8 berlaku untuk setiap pilihan pembiayaan, termasuk tarif.
6. Mutu sesuai standar	Layanan memenuhi standar nasional dan pedoman klinis yang berlaku, apa pun sumber dananya.
7. Akuntabilitas dan transparansi	Penggunaan dana dicatat per sumber, dilaporkan secara terbuka kepada pengawas dan komunitas, dan bebas dari pembiayaan ganda.

1.7 Cara Menggunakan Pedoman

Pedoman ini tidak harus dibaca berurutan. Mulailah dengan Bab 2 untuk menilai kesiapan dan menentukan tipe klinik, lalu ikuti jalur yang sesuai.

Tabel 1.1 Jalur baca menurut tahap

Jika klinik Anda…	Mulai dari	Lanjutkan ke
Baru akan didirikan, atau masih berupa layanan komunitas yang belum berizin	Bab 2, Bab 3	Bab 4, 5, 6, 8
Sudah berjalan dan ingin memperkuat fondasi	Bab 2, Bab 4	Bab 5, 6, 10
Menghadapi berkurangnya dukungan donor dalam 12–36 bulan	Bab 2, Bab 9	Bab 5, 6, 7, 8

Tabel 1.2 Penanda di dalam pedoman

Penanda	Isi
Pokok bab ini	Ringkasan hal yang akan Anda dapat dari bab
Contoh dari lapangan	Pengalaman CBC yang disajikan tanpa identitas (CBC A–G)
Daftar periksa	Langkah atau dokumen yang dapat langsung dicentang
Perhatian	Risiko, kesalahan yang sering terjadi, atau batasan

Setiap bab memiliki pasangan sesi pada Modul Pelatihan dan unit pada e-learning. Alat yang disebut dalam pedoman, seperti alat swa-nilai, kalkulator biaya, dan penyusun rencana transisi, tersedia dalam versi cetak di lampiran dan versi interaktif di e-learning.

Bab 2 Memahami CBC, Keberlanjutan, dan Tipologi Klinik

Pokok bab ini

- Pengertian CBC dan tiga model kepemilikannya
- Posisi CBC dalam sistem kesehatan dan paket layanannya
- Arti keberlanjutan operasional dan finansial, beserta sembilan domain kesiapan
- Empat tipe CBC dan cara menilai kesiapan klinik Anda sendiri

2.1 Apa Itu CBC

Pengertian

Community-Based Clinic (CBC) adalah klinik berizin yang layanannya ditujukan terutama bagi ODHIV, populasi kunci, serta komunitas rentan dan terdampak lainnya, yang memberikan layanan klinis HIV dan layanan terkait sesuai standar, dipadukan dengan layanan berbasis komunitas, dan melibatkan komunitas secara bermakna dalam tata kelola dan pemberian layanan.

Pengertian ini memuat empat unsur yang membedakan CBC dari klinik pada umumnya:

1. **Berizin.** CBC adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi ketentuan perizinan [11,12]. Layanan komunitas yang belum memiliki izin klinik sendiri, misalnya yang berjalan sebagai jejaring puskesmas, berada pada tahap pendirian atau transformasi (lihat Bab 3 dan Bab 9).
2. **Sasaran utama komunitas.** Layanan dirancang untuk ODHIV dan populasi kunci, tetapi klinik tetap boleh melayani masyarakat umum. Melayani masyarakat umum justru dapat memperkuat keberlanjutan.
3. **Klinis dan komunitas dalam satu alur.** Tes, pengobatan, dan pencegahan berjalan bersama penjangkauan, pendampingan, dan dukungan sebaya.
4. **Komunitas terlibat secara bermakna.** Komunitas ikut menentukan arah klinik, memberi layanan, dan memantau mutu.

Tiga model kepemilikan

Tabel 2.1 Model kepemilikan CBC

Aspek	Model 1: Milik komunitas	Model 2: Swasta bermitra dengan komunitas	Model 3: Kemitraan dengan pemerintah
Pemilik izin	Badan hukum organisasi komunitas (yayasan atau perkumpulan)	Badan usaha atau yayasan swasta	Organisasi komunitas atau swasta yang bekerja sama dengan Kemenkes atau Dinkes
Peran komunitas	Mendirikan, mengelola, dan memberi layanan	Ikut mengelola dan memberi layanan berdasarkan perjanjian	Memberi layanan dan menjangkau komunitas dalam kerangka program pemerintah
Kekuatan	Kepercayaan komunitas tinggi; misi jelas	Manajemen dan modal lebih kuat; peluang subsidi silang	Akses ke komoditas program dan jejaring layanan publik
Risiko keberlanjutan	Modal dan kapasitas manajemen terbatas	Misi sosial dapat bergeser ke orientasi pendapatan	Ketergantungan pada keberlanjutan program dan anggaran pemerintah

Aspek	Model 1: Milik komunitas	Model 2: Swasta bermitra dengan komunitas	Model 3: Kemitraan dengan pemerintah
Yang perlu dijaga	Sistem keuangan, perizinan, dan SDM yang kuat	Perjanjian tertulis tentang peran dan hak komunitas	Kontrak atau perjanjian kerja sama yang jelas jangka waktunya

UNAIDS membedakan respons yang **dipimpin** komunitas (community-led) dari respons yang **berbasis** komunitas (community-based). Organisasi disebut dipimpin komunitas bila sebagian besar tata kelola, kepemimpinan, staf, juru bicara, anggota, dan relawannya berasal dari dan mewakili komunitas yang dilayani, serta memiliki mekanisme akuntabilitas yang transparan kepada komunitas tersebut [17]. CBC Model 1 umumnya memenuhi kriteria ini. CBC Model 2 dan 3 belum tentu memenuhinya.

Karena itu, pedoman ini menetapkan **standar minimal keterlibatan komunitas** yang berlaku untuk semua model:

- ada perwakilan komunitas atau ODHIV dalam badan pengawas atau forum pengambilan keputusan klinik;
- ada pendamping sebaya atau petugas dari komunitas yang menjadi bagian tetap dari tim layanan;
- ada mekanisme umpan balik dan pengaduan pengguna yang hasilnya dibahas dan ditindaklanjuti; dan
- keputusan yang memengaruhi akses, seperti tarif, jam layanan, atau pengalihan fungsi, dibahas bersama komunitas sebelum diberlakukan.

Standar ini sejalan dengan target global bahwa porsi layanan yang diberikan organisasi yang dipimpin komunitas terus meningkat, yaitu 30% layanan tes dan pengobatan, 80% layanan pencegahan bagi populasi kunci, dan 60% program pendukung lingkungan sosial [18], serta dengan pedoman WHO untuk populasi kunci [19].

2.2 Posisi CBC dalam Sistem Kesehatan

CBC dapat memainkan beberapa peran sekaligus dalam sistem kesehatan. Setiap peran membuka jalur pembiayaan yang berbeda, sehingga mengenali peran ini penting sebelum menyusun kombinasi pembiayaan di Bab 6.

Tabel 2.2 Peran CBC dan jalur pembiayaan terkait

Peran CBC	Dasar	Hubungan utama	Jalur pembiayaan terkait
Fasilitas pelayanan kesehatan	UU 17/2023; PP 28/2024 [11,12]	Dinas Kesehatan (perizinan, pembinaan)	Pendapatan layanan; komoditas program
Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) mitra JKN	Fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan **dapat** bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; FKTP memberikan pelayanan nonspesialistik [13]	BPJS Kesehatan	Kapitasi dan non-kapitasi
Bagian jejaring layanan HIV	Peran serta masyarakat dalam penanggulangan HIV dikoordinasikan dengan puskesmas, Dinkes, atau Kemenkes [2]	Puskesmas, rumah sakit rujukan, Dinkes	Komoditas program (ARV, reagen); dukungan program
Pelaksana swakelola tipe III	Organisasi kemasyarakatan dapat menjadi pelaksana swakelola melalui kontrak dengan pejabat pembuat komitmen [14]	Dinas Kesehatan atau perangkat daerah lain	APBD melalui kontrak swakelola

Peran CBC	Dasar	Hubungan utama	Jalur pembiayaan terkait
Mitra program dan donor	Perjanjian hibah atau kerja sama	Kemenkes, penerima hibah utama, donor	Hibah program (selama masa transisi)

Perhatian

FKTP memberikan pelayanan nonspesialistik [13]. Klinik yang berizin sebagai **klinik utama** menyelenggarakan pelayanan spesialistik, sehingga jalur kerja sama sebagai FKTP umumnya ditempuh melalui klinik pratama. Dua dari tujuh CBC dalam self-assessment berizin klinik utama. Pilihan bagi klinik seperti ini dibahas di Bab 3 dan Bab 7.

2.3 Paket Layanan CBC

Paket layanan CBC terdiri atas layanan klinis inti dan layanan komunitas pendukung. Tabel berikut menunjukkan sumber pembiayaan yang umum saat ini. Rincian pilihan pembiayaan setelah transisi dibahas di Bab 6.

Tabel 2.3 Paket layanan CBC dan sumber pembiayaan saat ini

Kelompok layanan	Contoh layanan	Sumber pembiayaan yang umum saat ini
Tes dan diagnosis	Konseling dan tes HIV, tes sifilis, hepatitis B dan C, skrining TB, viral load	Reagen program pemerintah; jasa layanan dari donor, JKN, atau pengguna
Pengobatan dan perawatan	Inisiasi dan lanjutan ARV, tata laksana IMS, infeksi oportunistik, TB-HIV	ARV dari pemerintah; diagnosis dan layanan terkait dapat dibayar JKN [20]
Pencegahan	PrEP, PEP, kondom dan pelicin, layanan alat suntik steril, terapi rumatan	Komoditas program; jasa layanan dari donor
Layanan terkait	Kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi, layanan umum	Pengguna, JKN, atau sumber lain
Layanan komunitas	Penjangkauan, pendampingan sebaya, navigasi layanan, pelacakan pasien yang putus berobat, dukungan kepatuhan	Sebagian besar donor; sebagian kecil APBD
Fungsi pendukung	Pencatatan dan pelaporan SIHA, manajemen logistik, administrasi	Donor dan klinik

Layanan komunitas dan fungsi pendukung adalah bagian yang paling bergantung pada donor dan paling berisiko hilang. Padahal fungsi inilah yang membuat CBC berbeda dari fasilitas lain. Pedoman WHO tentang penyelenggaraan layanan HIV mendukung peran ini, antara lain melalui dukungan sebaya, navigasi layanan, dan desentralisasi layanan ke tingkat komunitas [9].

2.4 Keberlanjutan Operasional dan Finansial

Pengertian

Keberlanjutan CBC adalah kemampuan klinik untuk terus memberikan layanan HIV dan layanan komunitas yang bermutu, terjangkau, dan diterima komunitas, dengan sumber daya yang dapat diandalkan, ketika dukungan dari sumber tertentu, termasuk donor, berkurang atau berakhir.

Pengertian ini menegaskan bahwa keberlanjutan bukan sekadar klinik bertahan secara keuangan. Klinik yang bertahan dengan menaikkan tarif sampai pengguna paling rentan berhenti datang tidak dapat disebut berkelanjutan. Keberlanjutan dilihat dari dua dimensi kesiapan dan satu syarat.

Komponen	Pertanyaan kunci	Domain
Kesiapan kelembagaan dan regulasi (operasional)	Apakah klinik punya izin, tata kelola, SDM, sistem, dan kemitraan yang membuatnya tetap berjalan meskipun staf atau sumber dana berganti?	A, B, D, E, F, G, H
Kesiapan finansial	Apakah pendapatan klinik cukup, beragam, dapat diprediksi, dan dikelola dengan baik?	C
Syarat akses dan keterlibatan komunitas (guardrail)	Apakah layanan tetap terjangkau, rahasia, dan diterima komunitas?	I

Domain I tidak dimasukkan ke skor kesiapan. Domain ini menjadi syarat: rencana keberlanjutan apa pun harus lolos uji akses di Bab 8.

Sembilan domain kesiapan

Sembilan domain berikut dikembangkan dari kerangka building blocks sistem kesehatan WHO [21] dan disesuaikan dengan kebutuhan transisi pembiayaan program HIV [8,22].

Tabel 2.4 Domain kesiapan keberlanjutan CBC

Domain	Yang dinilai	Kaitan dengan building blocks WHO
A. Tata kelola dan kepemimpinan	Struktur, badan pengawas, mekanisme keputusan, SOP	Kepemimpinan dan tata kelola
B. Perencanaan strategis	Rencana kerja, rencana transisi, target pendapatan non-donor, fungsi berisiko	Kepemimpinan dan tata kelola
C. Stabilitas pendanaan dan manajemen keuangan	Keragaman sumber, laporan per sumber dana, audit, biaya per layanan, cadangan kas	Pembiayaan kesehatan
D. Sumber daya manusia	Kecukupan staf, retensi staf kunci, dampak pergantian staf, transfer pengetahuan	Tenaga kesehatan
E. Sistem informasi dan pemantauan	Pencatatan volume, pelaporan SIHA, pemakaian data, kemandirian sistem dari donor	Sistem informasi kesehatan
F. Logistik dan rantai pasok	Pencatatan stok, kekosongan stok, jalur pengadaan pascadonor	Produk medis dan teknologi
G. Kemitraan dan jejaring	Perjanjian rujukan, komunikasi dengan Dinkes, penjajakan dana daerah dan CSR, jaringan komunitas	Penyelenggaraan layanan; tata kelola
H. Perizinan dan kepatuhan	Izin operasional, kerja sama BPJS, pemahaman syarat dana publik	Tata kelola; pembiayaan kesehatan
I. Akses, mutu, dan keterlibatan komunitas	Kebijakan kerahasiaan, keringanan biaya, pemakaian masukan pengguna	Penyelenggaraan layanan

Tiga salah kaprah tentang keberlanjutan

- **"Berkelanjutan berarti menarik tarif."** Tarif hanya satu sumber, dan sering kali bukan yang terbesar. Dana publik (JKN dan APBD) umumnya lebih besar dan lebih stabil.
- **"Berkelanjutan berarti mencari donor pengganti."** Donor baru dapat menunda masalah, tetapi tidak menyelesaikannya. Arah kebijakan nasional dan global adalah pembiayaan domestik [3,5].
- **"Semua fungsi harus dipertahankan seperti sekarang."** Sebagian fungsi lebih tepat diintegrasikan, diefisienkan, atau diserahkan ke mitra. Yang wajib dijaga adalah akses dan mutu bagi pengguna.

2.5 Tingkat Kesiapan

Skor setiap domain dan dimensi dihitung dari alat swa-nilai (Lampiran 1) pada skala 1–4, lalu dikonversi menjadi empat tingkat kesiapan.

Tabel 2.5 Tingkat kesiapan

Tingkat	Rentang skor	Gambaran
Merintis (emerging)	1,00–1,75	Sebagian besar hal belum ada atau baru dibicarakan. Klinik sangat bergantung pada satu sumber dan satu atau dua orang kunci.
Berkembang (progressing)	1,76–2,50	Sudah dimulai tetapi belum rutin atau belum tertulis. Klinik rentan bila ada gangguan dana atau pergantian staf.
Mapan (established)	2,51–3,25	Sudah rutin dan sebagian besar terdokumentasi. Klinik siap mulai menempuh jalur dana publik.
Maju (advanced)	3,26–4,00	Rutin, terdokumentasi, dipantau, dan tetap berjalan meskipun ada pergantian staf.

Klinik dianggap **siap** menghadapi transisi bila kesiapan kelembagaan dan kesiapan finansialnya sama-sama di atas 2,50 (tingkat mapan atau maju). Ambang ini bersifat indikatif dan akan ditinjau setelah pedoman diujicobakan.

2.6 Empat Tipe CBC

Tipe klinik menentukan jalur tindakan yang paling tepat. Tipe ditentukan dengan empat pertanyaan berurutan (Lampiran 2).

Gambar 2.1 Langkah menentukan tipe klinik

Langkah 1	Apakah klinik memiliki izin klinik yang masih berlaku atas nama badan hukum pemiliknya?	Tidak → **Tipe 4**	Ya → Langkah 2
Langkah 2	Apakah skor kesiapan finansial (domain C) lebih dari 2,50?	Tidak → **Tipe 3**	Ya → Langkah 3
Langkah 3	Apakah klinik sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan atau kontrak aktif dengan pemerintah daerah?	Tidak → **Tipe 2**	Ya → **Tipe 1**

Tabel 2.6 Tipe CBC dan prioritas tindakan

Tipe	Ciri	Prioritas tindakan	Bab utama
Tipe 1 Terhubung dana publik	Berizin, sudah bermitra dengan BPJS atau punya kontrak pemda, kesiapan kelembagaan dan finansial mapan	• Optimalkan kapitasi dan non-kapitasi • Cegah pembiayaan ganda • Tambah kontrak pemda • Jaga akses kelompok tanpa JKN	6, 7, 8
Tipe 2 Mapan, belum terhubung dana publik	Kelembagaan mapan atau maju, keuangan cukup sehat, tetapi belum bermitra dengan BPJS dan belum punya kontrak pemda	• Kredensialing JKN, termasuk penyesuaian izin bila perlu • Swakelola tipe III • Costing sebagai dasar negosiasi	3, 5, 7

Tipe	Ciri	Prioritas tindakan	Bab utama
Tipe 3 Rentan finansial	Kesiapan finansial merintis atau berkembang, cadangan kas rendah, sumber pendapatan sempit	• Costing dan arus kas darurat • Tetapkan fungsi prioritas • Mobilisasi dana daerah dan filantropi • Minta pendampingan intensif	5, 6, 9
Tipe 4 Belum berizin mandiri	Layanan komunitas yang berjalan di bawah jejaring puskesmas atau fasilitas lain, tanpa izin klinik sendiri	• Pilih jalur: tetap sebagai jejaring dengan kontrak swakelola, atau mendirikan klinik pratama	3, 7, 9

Tipe bukan peringkat. Klinik dapat berpindah tipe seiring waktu, dan tujuan pedoman ini adalah membantu setiap klinik bergerak menuju Tipe 1 tanpa kehilangan karakter komunitasnya.

2.7 Menilai Kesiapan Klinik Sendiri

Lakukan swa-nilai minimal sekali setahun, dan setiap kali ada perubahan besar seperti berkurangnya dukungan donor atau pergantian pimpinan.

Langkah-langkah

1. **Bentuk tim penilai** yang terdiri atas 2–3 orang dengan peran berbeda: pimpinan atau penanggung jawab, bagian keuangan atau administrasi, dan perwakilan komunitas atau pendamping sebaya.
2. **Isi Lampiran 1 secara terpisah.** Setiap orang mengisi sendiri tanpa berdiskusi, sesuai kondisi saat ini dan bukan rencana. Pilih "TT" (tidak tahu) hanya bila benar-benar tidak mengetahui.
3. **Hitung skor domain** setiap penilai, yaitu rata-rata butir dalam domain tanpa menghitung jawaban TT. Domain dengan lebih dari separuh jawaban TT ditandai "data tidak cukup".
4. **Hitung skor klinik**, yaitu rata-rata skor semua penilai untuk setiap domain.
5. **Bahas perbedaan.** Butir dengan selisih skor antarpenilai 1,5 poin atau lebih menandakan pemahaman yang berbeda. Diskusikan bukti yang ada, misalnya dokumen atau laporan, lalu sepakati kondisi sebenarnya.
6. **Tentukan tingkat dan tipe.** Hitung kesiapan kelembagaan (rata-rata domain A, B, D, E, F, G, H) dan kesiapan finansial (domain C), konversi ke tingkat kesiapan (Tabel 2.5), lalu tentukan tipe klinik (Lampiran 2).
7. **Tetapkan tiga prioritas.** Pilih tiga butir terlemah yang paling menentukan keberlanjutan klinik, lalu masukkan ke rencana kerja atau rencana transisi (Bab 9).

> **Gambaran tujuh CBC (Oktober 2026)**
>
> Tujuh CBC yang didukung Kementerian Kesehatan melalui pembiayaan Global Fund melakukan swa-nilai dengan 23 penilai. Lima klinik mencapai tingkat siap pada kedua dimensi, dan dua klinik belum mencapainya karena kesiapan finansial yang rendah. Sebaran tipenya: satu klinik Tipe 1, tiga klinik Tipe 2, dua klinik Tipe 3, dan satu klinik Tipe 4.
>
> Polanya konsisten. Hal yang dikerjakan setiap hari sudah kuat, seperti komunikasi dengan Dinas Kesehatan (rata-rata 3,71), pelaporan SIHA (3,62), dan SOP tertulis (3,57). Hal yang menentukan apakah klinik bisa hidup setelah donor keluar masih lemah, seperti kerja sama dengan BPJS (1,49), pemahaman syarat dana publik (2,02), dan jalur pengadaan bila suplai program berhenti (2,26).

Tabel 2.7 Skor domain tujuh CBC sebagai pembanding

Klinik	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kelemb.	Finansial	Tipe
CBC A	3,33	2,92	3,20	2,92	3,42	3,33	3,25	3,33	3,22	3,21	3,20	**1**
CBC B	3,73	2,67	2,60	3,00	2,92	2,11	2,83	1,22	3,33	2,64	2,60	**4**
CBC C	3,50	2,50	2,60	2,81	3,25	3,00	3,63	2,92	3,75	3,09	2,60	**2**
CBC D	2,95	2,31	1,24	2,06	2,56	2,17	2,56	1,67	2,17	2,33	1,24	**3**
CBC E	3,47	2,67	3,40	2,25	3,25	2,89	3,31	2,11	3,00	2,85	3,40	**2**
CBC F	3,67	3,08	3,27	3,33	3,75	3,33	3,58	2,22	3,00	3,28	3,27	**2**
CBC G	3,00	2,50	2,20	2,50	3,00	3,00	3,00	2,00	2,67	2,71	2,20	**3**

Sumber: self-assessment kapasitas klinik, 23 responden dari 7 CBC, Oktober 2026 (data tidak dipublikasikan). Nama klinik dianonimkan. Warna mengikuti Tabel 2.5.

Langkah berikutnya

- Tipe 1 dan Tipe 2: lanjutkan ke Bab 5 (biaya dan pendapatan), lalu Bab 7 (kredensialing JKN dan kontrak pemerintah).
- Tipe 3: mulai dari Bab 5 untuk menghitung kebutuhan minimum, lalu Bab 9 untuk menetapkan fungsi prioritas.
- Tipe 4: lanjutkan ke Bab 3 untuk memilih jalur perizinan.
- Semua tipe: periksa guardrail akses di Bab 8 sebelum mengubah tarif atau model layanan.

Bab 3 Mendirikan CBC

Pokok bab ini

- Menilai kebutuhan wilayah dan kelayakan klinik sebelum mendirikan
- Memilih bentuk badan hukum dan jenis klinik yang membuka akses ke dana publik
- Langkah perizinan melalui OSS dan kewajiban setelah izin terbit
- Merancang layanan yang ramah komunitas sejak hari pertama

Bab ini ditujukan bagi komunitas atau organisasi yang akan mendirikan CBC, layanan komunitas yang belum memiliki izin klinik sendiri (Tipe 4), dan klinik yang perlu mengubah bentuk izinnya agar dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Keputusan yang diambil pada tahap pendirian, seperti bentuk badan hukum, jenis klinik, dan lokasi, menentukan sumber dana mana yang kelak dapat diakses. Karena itu, keputusan tersebut perlu diambil dengan memikirkan keberlanjutan sejak awal.

3.1 Menilai Kebutuhan dan Kelayakan

Kebutuhan wilayah

Sebelum mendirikan klinik, jawab lima pertanyaan berikut dengan data, bukan perkiraan:

1. **Seberapa besar beban HIV di wilayah ini?** Gunakan data Dinas Kesehatan dan SIHA: jumlah ODHIV yang ditemukan, yang menjalani ARV, dan yang putus berobat.
2. **Siapa yang belum terjangkau?** Perkirakan populasi kunci di wilayah layanan dan kelompok yang paling jarang datang ke fasilitas yang ada.
3. **Layanan apa yang sudah ada?** Petakan puskesmas dan rumah sakit yang memberikan layanan tes dan ARV, beserta jam layanan, keramahan, dan lokasinya.
4. **Kesenjangan apa yang akan diisi CBC?** Misalnya jam layanan malam, layanan ramah waria, pendampingan bagi pengguna napza, atau lokasi yang lebih dekat dengan komunitas.
5. **Siapa calon mitra?** Puskesmas rujukan, laboratorium viral load, Dinas Kesehatan, jaringan komunitas, dan calon penyandang dana.

Kelayakan klinik

Studi kelayakan sederhana menilai lima aspek: permintaan layanan, rancangan layanan, lokasi dan sarana, SDM, serta keuangan. Aspek keuangan mencakup biaya awal, biaya operasional bulanan, dan sumber dana untuk tiga tahun pertama. Templat studi kelayakan tersedia di Lampiran 4.

Perhatian

Jangan mendirikan klinik hanya karena tersedia hibah. Klinik yang dibangun dengan dana hibah tanpa rencana pembiayaan lanjutan akan menghadapi masalah yang sama dengan yang kini dihadapi banyak CBC. Rencana keuangan perlu menunjukkan bagaimana klinik dibiayai pada tahun keempat bila hibah tidak lagi tersedia.

3.2 Memilih Bentuk Badan Hukum Pemilik

Klinik swasta dimiliki oleh badan hukum. Bentuk badan hukum memengaruhi akses ke kontrak pemerintah, perlakuan pajak, dan cara klinik mengelola surplus. Organisasi kemasyarakatan dapat berbentuk badan hukum yayasan atau perkumpulan [23].

Tabel 3.1 Perbandingan bentuk badan hukum pemilik CBC

Aspek	Yayasan	Perkumpulan	Badan usaha (PT, koperasi)
Sifat	Nirlaba; kekayaan dipisahkan untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan [24]	Nirlaba berbasis anggota	Mencari laba (koperasi berbasis anggota)
Kesesuaian dengan misi komunitas	Tinggi	Tinggi; anggota dapat berasal dari komunitas	Perlu perjanjian tertulis agar misi dan peran komunitas terjaga
Pelaksana swakelola tipe III	Dapat, sebagai organisasi kemasyarakatan	Dapat, sebagai organisasi kemasyarakatan	Tidak; badan usaha mengikuti jalur pengadaan melalui penyedia
Kerja sama dengan BPJS Kesehatan	Dapat, bila klinik memenuhi persyaratan	Dapat, bila klinik memenuhi persyaratan	Dapat, bila klinik memenuhi persyaratan
Pengelolaan surplus	Dikembalikan untuk kegiatan yayasan; tidak dibagikan kepada pembina, pengurus, atau pengawas	Dikembalikan untuk tujuan perkumpulan	Dapat dibagikan kepada pemegang saham atau anggota
Catatan bagi CBC	Bentuk paling umum untuk CBC milik komunitas	Cocok bila komunitas ingin tata kelola berbasis anggota	Cocok untuk Model 2 (swasta bermitra dengan komunitas)

Banyak CBC memiliki klinik di bawah yayasan yang juga menjalankan program komunitas. Bila demikian, pisahkan pencatatan keuangan klinik dari program lain sejak awal. Pemisahan ini memudahkan perhitungan biaya klinik, audit, dan pengajuan kontrak (lihat 4.7 dan Bab 5).

3.3 Memilih Jenis Klinik

Klinik swasta dibedakan menjadi klinik pratama, klinik utama, dan klinik pratama pendukung [25]. Klinik pratama menyelenggarakan pelayanan medik dasar, sedangkan klinik utama menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau gabungan pelayanan medik dasar dan spesialistik. Perbedaan ini sangat penting bagi keberlanjutan karena menentukan posisi klinik dalam JKN.

Tabel 3.2 Jenis klinik dan posisinya dalam JKN

Aspek	Klinik pratama	Klinik utama
Pelayanan	Medik dasar, umum maupun khusus	Medik spesialistik, atau dasar dan spesialistik
Posisi dalam JKN	**Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)** [26]	**Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL)** [26]
Cara dibayar BPJS	Kapitasi bulanan per peserta terdaftar, ditambah non-kapitasi untuk layanan tertentu	Per kasus berdasarkan rujukan dari FKTP
Arus pengguna	Pengguna mendaftar sebagai peserta di klinik	Pengguna datang dengan rujukan dari FKTP
Kecocokan dengan layanan inti CBC	Tinggi: tes HIV, ARV, PrEP, IMS, dan pendampingan adalah layanan tingkat pertama	Rendah untuk layanan inti; sesuai bila klinik menyediakan layanan spesialis

Bagi sebagian besar CBC, **klinik pratama adalah pilihan yang paling sesuai**. Sebagian besar layanan inti CBC adalah layanan tingkat pertama, dan hanya FKTP yang menerima kapitasi, yaitu pendapatan bulanan yang dapat diprediksi.

Bila klinik Anda saat ini berizin klinik utama

Dua dari tujuh CBC dalam self-assessment berizin klinik utama dan belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ada tiga pilihan yang dapat dijajaki bersama Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan setempat:

Pilihan	Penjelasan	Pertimbangan
A. Mengubah izin menjadi klinik pratama	Klinik mengajukan perubahan jenis izin melalui OSS	Layanan spesialis yang ada perlu dirujuk atau dihentikan
B. Mendirikan klinik pratama terpisah	Badan hukum yang sama atau mitra mendirikan klinik pratama dengan izin tersendiri	Membutuhkan ruang, SDM, dan izin terpisah sesuai standar
C. Tetap sebagai klinik utama	Klinik mengandalkan rujukan JKN, pendapatan layanan, dan kontrak pemerintah	Tidak ada kapitasi; layanan inti HIV tetap bergantung pada sumber non-JKN

> **Perhatian**
>
> Ketentuan teknis perubahan jenis izin dan kemungkinan menjalankan dua jenis klinik di satu lokasi perlu dikonfirmasi ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebelum keputusan diambil.

Bila layanan Anda belum memiliki izin klinik sendiri

Layanan komunitas yang berjalan sebagai jejaring puskesmas (Tipe 4) memiliki dua jalur. **Jalur pertama** adalah tetap sebagai jejaring, dengan memperkuat perjanjian kerja sama dengan puskesmas dan menempuh kontrak swakelola tipe III untuk layanan komunitas (Bab 7). Jalur ini cocok bila layanan klinis dapat tetap diberikan oleh puskesmas. **Jalur kedua** adalah mendirikan klinik pratama sendiri. Jalur ini cocok bila komunitas membutuhkan layanan klinis di lokasi komunitas dan organisasi siap memenuhi standar perizinan. Pilihan di antara keduanya dibahas lebih lanjut di Bab 9.

3.4 Langkah Perizinan

Perizinan klinik mengikuti sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS [27]. Standar kegiatan usaha untuk klinik diatur dalam Permenkes 11/2025, yang ditetapkan pada 3 Oktober 2025 dan menggantikan ketentuan sebelumnya sepanjang mengatur hal yang sama [25]. Izin yang terbit sebelum sistem baru tetap berlaku, sedangkan permohonan yang masih berproses dilanjutkan dengan ketentuan lama.

Tabel 3.3 Langkah perizinan klinik pratama

Langkah	Kegiatan	Yang perlu disiapkan
1	Siapkan legalitas badan hukum dan Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS	Akta pendirian dan pengesahan badan hukum; pilih KBLI yang sesuai untuk klinik
2	Penuhi persyaratan dasar	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung (PBG), dan sertifikat laik fungsi (SLF) [25]

Langkah	Kegiatan	Yang perlu disiapkan
3	Siapkan dokumen klinik	Profil klinik, surat penetapan dokter penanggung jawab, swa-nilai standar, peraturan internal klinik, daftar obat dan BMHP, dokumen pengelolaan limbah [28]
4	Pastikan SDM memenuhi syarat	Tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP di klinik ini; jumlah dan jenis tenaga sesuai lampiran standar
5	Ajukan permohonan melalui OSS	Verifikasi dilakukan tim DPMPTSP dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota; izin klinik diterbitkan paling lama 25 hari kerja [28]
6	Izin terbit	Simpan dokumen izin; catat masa berlaku dan kewajiban pembaruan

Hal yang sering menghambat perizinan

- Bangunan sewaan belum memiliki PBG dan SLF, atau pemilik bangunan tidak bersedia mengurusnya.
- Lokasi tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- Dokter penanggung jawab belum memiliki SIP di klinik tersebut.
- Belum ada kerja sama dengan pengolah atau pengangkut limbah medis berizin.
- Denah ruang tidak memenuhi standar, misalnya ruang tindakan atau ruang farmasi.

Daftar periksa dokumen perizinan tersedia di Lampiran 3. Rincian jumlah minimal tenaga, ruang, dan peralatan mengikuti lampiran Permenkes 11/2025. Periksa versi terbarunya di OSS atau di Dinas Kesehatan sebelum mengajukan permohonan.

3.5 Kewajiban Setelah Izin Terbit

Kewajiban	Keterangan	Kaitan dengan keberlanjutan
Akreditasi	Klinik wajib diakreditasi [29]; klinik baru memperoleh akreditasi dalam dua tahun setelah izin terbit [28]	Akreditasi menjadi pertimbangan dalam kredensialing BPJS Kesehatan (Bab 7)
Rekam medis elektronik	Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik yang terhubung dengan SATUSEHAT [15]	Syarat kerja sama dan klaim; pilih sistem yang tidak bergantung pada lisensi donor
Akun SIHA dan pelaporan	Klinik yang memberi layanan HIV melapor ke SIHA melalui Dinas Kesehatan	Dasar alokasi komoditas program dan bukti kinerja untuk kontrak
Akses komoditas program	Ajukan sebagai layanan tes dan perawatan HIV kepada Dinas Kesehatan agar menerima ARV, reagen, dan komoditas program	Komoditas program menekan biaya klinik secara bermakna
Kerja sama dengan BPJS Kesehatan	Bagi klinik pratama yang memenuhi persyaratan (Bab 7)	Sumber pendapatan rutin melalui kapitasi

3.6 Merancang Layanan Ramah Komunitas Sejak Awal

Kekuatan CBC terletak pada kepercayaan komunitas. Kepercayaan ini dibangun melalui rancangan layanan, bukan hanya sikap petugas.

- **Jam layanan** mengikuti kebutuhan pengguna, termasuk sore dan malam hari bila pengguna bekerja pada siang hari.
- **Alur satu pintu**: pendaftaran, konseling, tes, pengambilan obat, dan pendampingan sedapat mungkin di satu lokasi, dengan waktu tunggu singkat.

- **Privasi ruang**: ruang konseling tertutup dan ruang tunggu yang tidak memperlihatkan alasan kunjungan.
- **Nama dan tampilan klinik** tidak memberi label HIV, agar pengguna tidak merasa terekspos saat datang.
- **Layanan umum** bagi masyarakat sekitar membantu menyamarkan alasan kunjungan dan membuka peluang subsidi silang.
- **Petugas dari komunitas** menjadi bagian tetap tim layanan sejak awal.
- **Keterlibatan komunitas dalam tata kelola** sesuai standar minimal di Bab 2.

Contoh dari lapangan

Satu CBC menandatangani sewa lahan dan bangunan jangka panjang selama sepuluh tahun (2026–2036) agar lokasi layanan stabil dan dikenal komunitas. Sebaliknya, klinik lain masih menyewa lahan dengan kontrak pendek dan memiliki ruang yang sempit, sehingga privasi pengguna sulit dijaga ketika kunjungan ramai. Status lokasi dan kecukupan ruang perlu masuk perhitungan sejak tahap pendirian.

Langkah berikutnya

- Setelah izin terbit, perkuat fondasi organisasi dengan Bab 4.
- Hitung biaya awal dan biaya operasional dengan Bab 5.
- Klinik pratama yang siap dapat langsung menyiapkan kredensialing BPJS Kesehatan (Bab 7).

Bab 4 Tata Kelola, SDM, dan Sistem Operasional

Pokok bab ini

- Tata kelola yang tetap berjalan meskipun pimpinan atau sumber dana berganti
- Hierarki rencana, dari rencana strategis sampai rencana kerja tahunan
- Mempertahankan staf kunci dan pengetahuan kerja
- Sistem informasi, logistik, kemitraan, dan pengendalian keuangan yang mandiri dari donor

Bab ini membahas domain A, B, D, E, F, dan G pada alat swa-nilai. Fondasi organisasi yang kuat adalah prasyarat bagi semua jalur pembiayaan. BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan mitra swasta akan menilai apakah klinik dapat diandalkan sebelum membiayainya.

Contoh dari lapangan

Pada tujuh CBC, tata kelola adalah domain terkuat (rata-rata 3,38), disusul kemitraan (3,17) dan sistem informasi (3,16). Kelemahan justru muncul pada butir yang berkaitan dengan masa setelah donor: rencana tertulis menghadapi berakhirnya donor (2,43), rencana mempertahankan staf kunci (2,44), sistem pencatatan yang tetap berjalan tanpa dukungan donor (2,50), dan jalur pengadaan bila suplai program berhenti (2,26).

4.1 Tata Kelola dan Kepemimpinan

Tata kelola yang baik memastikan keputusan penting diambil dengan benar, tercatat, dan diawasi. Lima unsur berikut perlu ada di setiap CBC:

Unsur	Yang dimaksud	Bukti
Struktur organisasi tertulis	Pembagian tugas dan wewenang antara pemilik, pengawas, pimpinan klinik, dan unit layanan	Bagan struktur dan uraian tugas
Badan pengawas	Pengurus yayasan, dewan, atau pemilik yang meninjau kinerja dan keuangan klinik secara berkala	Notulen rapat pengawas minimal triwulanan
Pemisahan peran	Pengawas tidak sekaligus menjalankan operasional sehari-hari; konflik kepentingan dicatat	Kebijakan konflik kepentingan
Mekanisme keputusan	Keputusan anggaran, tarif, dan layanan diambil melalui forum yang jelas	Notulen dan surat keputusan
Peraturan internal dan SOP	Peraturan internal klinik dan SOP layanan utama serta administrasi yang dipakai sehari-hari	Dokumen peraturan internal dan SOP yang diperbarui

Tambahkan **representasi komunitas** dalam badan pengawas atau forum keputusan, sesuai standar minimal keterlibatan komunitas di Bab 2. Pastikan juga bahwa pimpinan membahas keberlanjutan secara rutin. Jadikan keberlanjutan agenda tetap rapat pengawas, bukan topik yang baru dibicarakan ketika dana hampir habis.

4.2 Perencanaan Strategis dan Rencana Bisnis

Klinik membutuhkan empat lapis rencana yang saling terhubung:

Rencana	Jangka waktu	Isi pokok	Bab terkait
Rencana strategis	3–5 tahun	Visi, posisi klinik, layanan prioritas, target keberlanjutan	2, 9

Rencana	Jangka waktu	Isi pokok	Bab terkait
Rencana bisnis	3 tahun	Proyeksi volume, biaya, pendapatan per sumber, titik impas	5, 6
Rencana kerja dan anggaran tahunan	1 tahun	Kegiatan, target, anggaran per sumber dana, penanggung jawab	5
Rencana transisi	12–36 bulan	Klasifikasi fungsi, jalur transformasi, tonggak, risiko	9

Rencana bisnis sederhana untuk CBC cukup memuat tujuh bagian: ringkasan; layanan dan sasaran pengguna; analisis kebutuhan dan pesaing; rencana operasional (SDM, jam layanan, lokasi); rencana pembiayaan per sumber; proyeksi keuangan tiga tahun; serta risiko dan mitigasinya. Rencana bisnis ini juga menjadi bahan utama proposal ke pemerintah daerah dan mitra swasta.

4.3 Sumber Daya Manusia

Komposisi dan pembagian waktu

Tetapkan komposisi minimal tim untuk menjalankan layanan inti, misalnya dokter penanggung jawab, perawat atau bidan, tenaga kefarmasian, analis laboratorium bila ada, petugas administrasi dan keuangan, serta pendamping sebaya. Catat pembagian waktu setiap staf antarlayanan. Data ini dibutuhkan untuk menghitung biaya per layanan (Bab 5) dan untuk menunjukkan bahwa staf yang dibayar dari satu sumber tidak diklaim ke sumber lain.

Peta staf dan sumber honor

Buat tabel sederhana yang memuat setiap posisi, sumber honornya, dan kapan sumber itu berakhir. Peta ini menunjukkan posisi mana yang paling berisiko. Di tujuh CBC, hampir separuh responden menerima honor dari program Global Fund.

Mempertahankan staf kunci

Staf kunci adalah orang yang bila keluar akan menghentikan atau mengganggu layanan secara berarti, seperti dokter penanggung jawab, petugas pelaporan SIHA, petugas keuangan, dan pendamping sebaya senior. Strategi mempertahankan staf kunci antara lain:

- **memindahkan honor secara bertahap** ke sumber yang lebih stabil, seperti jasa pelayanan dari kapitasi JKN, kontrak swakelola, atau pendapatan layanan;
- **membagi pembiayaan satu posisi ke beberapa sumber** sesuai pembagian waktu kerja, agar posisi tidak hilang ketika satu sumber berhenti;
- **memberi kepastian**, misalnya kontrak kerja yang lebih panjang, jenjang tugas, dan pelatihan; dan
- **mengomunikasikan rencana transisi** kepada staf lebih awal agar staf tidak keluar karena ketidakpastian.

Templat rencana retensi staf kunci tersedia di Lampiran 6.

Pendamping sebaya

Pendamping sebaya adalah ciri khas CBC dan termasuk posisi yang paling bergantung pada donor. Strategi AIDS Global 2026–2031 meminta peran kader dan pendamping sebaya diformalkan dengan honor dan pelindungan [3]. Bagi CBC, ini berarti menuliskan uraian tugas pendamping sebaya, mencatat kontribusinya terhadap layanan (misalnya jumlah orang yang

dirujuk dan didampingi), dan memasukkan posisinya ke dalam proposal kontrak swakelola dan rencana anggaran klinik.

Pengetahuan kerja tidak boleh hanya dikuasai satu orang

- Tuliskan prosedur kerja penting dalam SOP, termasuk pelaporan SIHA, permintaan logistik, dan pengajuan klaim.
- Latih minimal dua orang untuk setiap tugas kritis.
- Simpan daftar kontak mitra, akun sistem, dan dokumen penting di tempat yang dapat diakses pimpinan.
- Pantau masa berlaku STR dan SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan.

4.4 Sistem Informasi dan Pemantauan

Fungsi	Praktik yang dianjurkan
Pencatatan layanan	Catat volume bulanan per jenis layanan dan per kelompok pengguna, termasuk peserta JKN dan non-JKN
Pelaporan nasional	Laporkan ke SIHA tepat waktu; pelaporan yang baik menjadi bukti kinerja untuk kontrak dan dasar alokasi komoditas
Rekam medis elektronik	Gunakan RME yang terhubung dengan SATUSEHAT [15]
Pemakaian data	Tinjau data bulanan untuk merencanakan staf, stok, dan jadwal; tampilkan dalam dasbor sederhana
Kemandirian dari donor	Pastikan sistem, lisensi, perangkat, dan petugas pencatatan tetap dapat berjalan bila dukungan donor berhenti
Kerahasiaan	Batasi akses data berdasarkan peran, gunakan kata sandi yang kuat, dan catat siapa yang mengakses data [10]

> **Perhatian**
>
> Bila sistem pencatatan klinik saat ini disediakan atau dibiayai donor, segera tanyakan apa yang terjadi pada data dan lisensinya setelah dukungan berakhir. Siapkan cara memindahkan data ke sistem yang dapat dibiayai klinik sendiri.

4.5 Logistik dan Rantai Pasok

Komoditas HIV adalah komponen biaya yang besar. Saat ini sebagian besar disediakan program pemerintah dan donor.

Tabel 4.1 Sumber komoditas dan langkah antisipasi

Komoditas	Sumber saat ini	Langkah antisipasi
Obat ARV	Disediakan pemerintah [20]	Jaga ketepatan pelaporan dan permintaan melalui Dinas Kesehatan
Reagen tes HIV, sifilis, hepatitis	Program pemerintah dan donor	Ketahui reagen mana yang dibiayai donor; siapkan jalur pembelian melalui distributor resmi dan hitung biayanya
Viral load dan pemeriksaan lanjutan	Rujukan ke laboratorium jejaring	Perkuat perjanjian rujukan sampel dan pengirimannya
Kondom, pelicin, alat suntik steril	Program dan donor	Petakan sumber alternatif: program Dinas Kesehatan, CSR, atau pembelian
Obat IMS, infeksi oportunistik, BMHP	Campuran: program, donor, pembelian klinik	Masukkan ke perhitungan biaya per layanan (Bab 5)

- Gunakan kartu stok atau sistem stok yang diperbarui setiap transaksi, dan terapkan prinsip yang kedaluwarsa lebih dulu keluar lebih dulu.
- Tetapkan stok minimal dan stok pengaman agar tidak terjadi kekosongan yang menghentikan layanan.
- Catat nilai komoditas yang diterima dari program sebagai **nilai in-kind**. Nilai ini dibutuhkan agar biaya layanan yang sebenarnya terlihat (Bab 5).

> **Contoh dari lapangan**
>
> Logistik obat, reagen, dan BMHP adalah salah satu dukungan yang paling sering disebut tujuh CBC untuk enam bulan ke depan. Empat dari tujuh klinik belum mengetahui jalur pengadaan bila suplai dari program atau donor berhenti.

4.6 Kemitraan dan Jejaring

- **Perjanjian rujukan tertulis** dengan puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium, termasuk rujuk balik dan pengiriman sampel.
- **Komunikasi rutin dengan Dinas Kesehatan.** Ini adalah kekuatan terbesar tujuh CBC (rata-rata 3,71). Manfaatkan hubungan ini untuk advokasi anggaran dan kontrak swakelola (Bab 7).
- **Jaringan komunitas** untuk penjangkauan, pendampingan, dan pemantauan layanan.
- **Mitra swasta dan filantropi**, misalnya perusahaan, Baznas, dan lembaga filantropi, untuk dukungan yang tidak dibiayai JKN atau APBD (Bab 6).

4.7 Manajemen Keuangan Dasar dan Pengendalian Internal

Pengelolaan keuangan yang tertib menjadi syarat untuk semua jalur dana publik dan swasta. Praktik dasar berikut perlu diterapkan sebelum klinik menghitung biaya dan menyusun kombinasi pembiayaan:

1. **Pisahkan pencatatan per sumber dana**, baik melalui rekening terpisah maupun kode akun, dan pisahkan keuangan klinik dari program lain yayasan.
2. **Buat laporan keuangan bulanan** yang menunjukkan pendapatan dan biaya per sumber dana.
3. **Terapkan otorisasi ganda** untuk pengeluaran di atas batas tertentu, dan pisahkan fungsi yang menyetujui, membayar, dan mencatat.
4. **Kelola kas kecil** dengan batas dan bukti yang jelas.
5. **Lakukan audit atau pemeriksaan independen** secara berkala; laporan audit memperkuat kredibilitas klinik di mata pemerintah dan mitra.
6. **Susun daftar risiko** keuangan dan operasional beserta langkah mitigasinya.

Daftar periksa kapasitas organisasi di Lampiran 5 membantu klinik menilai praktik di bab ini secara lebih rinci dibandingkan alat swa-nilai.

> **Langkah berikutnya**
>
> - Gunakan peta staf, pembagian waktu, dan nilai in-kind dari bab ini untuk menghitung biaya per layanan di Bab 5.
> - Masukkan butir yang belum terpenuhi dari Lampiran 5 ke rencana kerja tahunan atau rencana transisi (Bab 9).

Bab 5 Memetakan Biaya dan Pendapatan

Pokok bab ini

- Jenis biaya klinik, termasuk nilai in-kind yang sering terlupa
- Cara menghitung biaya per layanan dengan contoh angka
- Memetakan pendapatan dan menghitung kesenjangan pendanaan
- Arus kas, cadangan, dan titik impas

Klinik yang tidak mengetahui biayanya sendiri tidak dapat menegosiasikan kontrak, menetapkan tarif yang adil, atau menyusun rencana transisi yang realistis. Bab ini menjelaskan cara menghitung biaya dan memetakan pendapatan secara sederhana, cukup dengan lembar kerja di Lampiran 7 atau Simulator Keberlanjutan CBC (Lampiran 8).

Contoh dari lapangan

Hanya satu dari tujuh CBC yang skor butir "mengetahui biaya per jenis layanan utama" berada di bawah 2,50, tetapi kemampuan menghitung biaya per kunjungan masih bervariasi (rata-rata 2,62 dari 4). Cadangan kas minimal tiga bulan baru dimiliki sebagian klinik (rata-rata 2,40). Penyusunan rencana keuangan transisi, pemetaan biaya operasional, dan anggaran pascadonor termasuk dukungan yang paling banyak diminta pengelola.

5.1 Mengapa Menghitung Biaya Penting

Keputusan	Mengapa perlu data biaya
Negosiasi kontrak swakelola	Nilai kontrak perlu didasarkan pada biaya nyata per layanan atau per orang yang dilayani
Kerja sama JKN	Klinik perlu tahu apakah kapitasi untuk jumlah peserta tertentu menutup biaya layanan peserta tersebut
Penetapan tarif	Tarif tidak boleh lebih rendah dari biaya tanpa sumber subsidi yang jelas, dan tidak boleh melanggar guardrail akses (Bab 8)
Rencana transisi	Klinik perlu tahu kebutuhan dana minimum agar layanan inti tetap berjalan
Efisiensi	Biaya per layanan yang tinggi menunjukkan bagian yang perlu ditata ulang

5.2 Jenis Biaya

Jenis	Pengertian	Contoh di CBC
Biaya tetap	Tidak berubah meskipun jumlah kunjungan naik atau turun dalam rentang tertentu	Honor staf tetap, sewa, utilitas, penyusutan peralatan, lisensi sistem
Biaya variabel	Bertambah setiap ada kunjungan atau layanan	BMHP, reagen dan obat yang dibeli sendiri, transportasi pendampingan per kasus
Biaya langsung	Dapat dikaitkan langsung dengan satu layanan	Reagen tes HIV untuk layanan tes
Biaya tidak langsung	Mendukung banyak layanan sekaligus	Administrasi, kebersihan, pimpinan klinik
Nilai in-kind	Barang atau jasa yang diterima tanpa membayar	ARV dan reagen dari program, staf yang digaji pihak lain, ruang pinjaman, relawan

Jangan lupakan nilai in-kind

Bila komoditas program dan staf yang dibayar pihak lain tidak dihitung, biaya klinik tampak jauh lebih kecil daripada kenyataannya. Akibatnya, nilai kontrak dan tarif ditetapkan terlalu rendah, dan klinik terkejut ketika dukungan in-kind berhenti. Catat nilai in-kind secara terpisah, sehingga klinik dapat melihat **biaya tunai** (yang dibayar klinik) dan **biaya penuh** (tunai ditambah in-kind).

5.3 Menghitung Biaya per Layanan

Cara paling sederhana yang cukup akurat untuk CBC adalah membagi biaya tetap ke setiap layanan berdasarkan **bobot waktu**, lalu menambahkan biaya variabel per kunjungan.

1. **Kumpulkan biaya tetap bulanan** dari laporan keuangan, termasuk honor yang dibayar donor.
2. **Kumpulkan volume bulanan per layanan** dari pencatatan klinik atau SIHA.
3. **Tetapkan bobot waktu** setiap layanan dibandingkan layanan acuan. Misalnya, bila tes HIV dengan konseling rata-rata 30 menit diberi bobot 1,0, kunjungan ARV lanjutan 24 menit diberi bobot 0,8.
4. **Hitung unit tertimbang**: volume dikali bobot, lalu dijumlahkan.
5. **Hitung biaya tetap per unit tertimbang**: total biaya tetap dibagi total unit tertimbang.
6. **Hitung biaya per layanan**: biaya tetap per unit tertimbang dikali bobot layanan, ditambah biaya variabel per kunjungan.

Contoh 5.1 Biaya tetap bulanan klinik pratama fiktif

Komponen biaya tetap	Per bulan
Dokter penanggung jawab (1 orang)	Rp9.000.000
Perawat (2 orang)	Rp9.000.000
Tenaga kefarmasian (1 orang)	Rp4.000.000
Analis laboratorium (1 orang)	Rp4.200.000
Administrasi dan keuangan (1 orang)	Rp4.000.000
Pendamping sebaya (3 orang)	Rp9.000.000
Sewa bangunan	Rp6.000.000
Listrik, air, internet	Rp2.500.000
Penyusutan peralatan	Rp1.500.000
Sistem informasi dan administrasi umum	Rp1.300.000
Total biaya tetap	**Rp50.500.000**

Contoh 5.2 Biaya per layanan

Layanan	Volume	Bobot	Unit tertimbang	Biaya tetap per layanan	Biaya variabel	Biaya per layanan
Tes HIV	300	1,0	300	Rp61.585	Rp15.000	**Rp76.585**
Kunjungan ARV	450	0,8	360	Rp49.268	Rp15.000	**Rp64.268**
PrEP	100	1,0	100	Rp61.585	Rp15.000	**Rp76.585**
IMS	50	1,2	60	Rp73.902	Rp15.000	**Rp88.902**
Total	**900**		**820**			

Dalam contoh ini, biaya tetap per unit tertimbang adalah Rp50.500.000 dibagi 820, yaitu sekitar Rp61.585. Total biaya tunai bulanan adalah Rp50.500.000 ditambah 900 kunjungan dikali Rp15.000, yaitu Rp64.000.000, atau rata-rata Rp71.111 per kunjungan. Angka ini **belum** termasuk nilai ARV dan reagen dari program. Bila nilai in-kind ditambahkan, biaya penuh per layanan akan lebih tinggi.

Tips

- Gunakan rata-rata enam sampai dua belas bulan agar tidak terpengaruh bulan yang tidak biasa.
- Bila layanan komunitas (penjangkauan dan pendampingan) dicatat sebagai kegiatan tersendiri, hitung biayanya terpisah, misalnya biaya per orang yang dijangkau atau didampingi. Angka ini menjadi dasar proposal swakelola.
- Perbarui perhitungan setiap tahun atau ketika ada perubahan besar pada staf atau volume.

5.4 Memetakan Pendapatan

Petakan setiap sumber pendapatan dalam dua belas bulan terakhir menurut empat ciri: besarnya, porsinya, seberapa dapat diprediksi, dan kapan dana diterima. Tambahkan juga **matriks siapa membiayai apa**, yaitu tabel fungsi klinik dikali sumber dana. Matriks ini menunjukkan fungsi mana yang hilang bila satu sumber berhenti, dan mencegah satu biaya dibiayai dua sumber.

Contoh 5.3 Matriks siapa membiayai apa (sebagian)

Fungsi	Donor	Program pemerintah	JKN	APBD	Pendapatan layanan
Honor dokter penanggung jawab	60%				40%
Pendamping sebaya	100%				
ARV		100% (in-kind)			
Reagen tes HIV	30%	70% (in-kind)			
Sewa bangunan	50%				50%
Pelaporan SIHA	100%				

Angka fiktif untuk ilustrasi.

5.5 Arus Kas, Cadangan, dan Titik Impas

Kesenjangan pendanaan

Kesenjangan pendanaan adalah selisih antara biaya tunai bulanan dan pendapatan yang akan tetap ada setelah dukungan donor berakhir. Dalam contoh, bila biaya tunai Rp64.000.000 dan pendapatan non-donor hanya Rp8.000.000 dari layanan, kesenjangannya adalah Rp56.000.000 per bulan.

Daya tahan kas

Daya tahan kas adalah saldo kas dibagi kesenjangan bulanan. Dengan saldo Rp90.000.000, klinik dalam contoh hanya bertahan sekitar 1,6 bulan setelah donor berhenti. Angka ini menjawab pertanyaan pengelola: "Berapa lama klinik dapat bertahan dengan kas yang ada?"

Cadangan kas

Targetkan cadangan kas untuk minimal tiga bulan biaya operasional. Dalam contoh, targetnya Rp192.000.000. Cadangan dibangun bertahap dari surplus, misalnya dengan menyisihkan persentase tetap dari pendapatan layanan setiap bulan.

Titik impas

Titik impas adalah volume layanan atau jumlah peserta yang membuat pendapatan menutup biaya. Untuk klinik yang bekerja sama dengan BPJS, hitung jumlah peserta terdaftar yang dibutuhkan agar kapitasi, bersama sumber lain, menutup biaya tunai. Contohnya ada di Bab 6.

Proyeksi arus kas

Susun proyeksi arus kas bulanan untuk 12–36 bulan ke depan dengan tiga skenario: dasar, pesimis (misalnya dana pemda terlambat cair enam bulan), dan optimis. Proyeksi ini memperlihatkan bulan-bulan rawan, seperti awal tahun anggaran ketika dana daerah belum cair. Simulator Keberlanjutan CBC memuat lembar skenario untuk keperluan ini (Lampiran 8).

5.6 Laporan Keuangan yang Memisahkan Sumber Dana

Laporan bulanan sederhana cukup memuat lima bagian: pendapatan per sumber; biaya per jenis biaya; biaya per sumber dana yang membayarnya; nilai in-kind yang diterima; serta saldo kas dan perbandingannya dengan target cadangan. Laporan ini juga menjadi bahan audit dan pertanggungjawaban kontrak.

> **Langkah berikutnya**
>
> - Isi Lampiran 7 atau Simulator Keberlanjutan CBC dengan data dua belas bulan terakhir.
> - Bawa angka biaya per layanan, kesenjangan pendanaan, dan daya tahan kas ke Bab 6 untuk menyusun kombinasi pembiayaan.

Bab 6 Memilih Kombinasi Pembiayaan

Pokok bab ini

- Prinsip memilih sumber dana
- Peta sumber pembiayaan CBC dan syarat utamanya
- Contoh kombinasi pembiayaan untuk setiap tipe klinik
- Mencegah pembiayaan ganda

Tidak ada satu sumber dana yang dapat menggantikan donor sepenuhnya. Klinik yang berkelanjutan menggabungkan beberapa sumber yang saling melengkapi, dengan **dana publik sebagai tulang punggung**. Sumber lain mengisi kebutuhan yang tidak dibiayai dana publik.

6.1 Prinsip Memilih Sumber Dana

Kriteria	Pertanyaan
Prediktabilitas	Apakah dana datang rutin dan jumlahnya dapat diperkirakan?
Skala	Apakah besarnya sepadan dengan usaha untuk memperolehnya?
Kecocokan dengan misi	Apakah sumber ini mendukung layanan bagi kelompok yang paling rentan?
Biaya administrasi	Berapa besar beban pelaporan, audit, dan pengelolaannya?
Risiko terhadap akses	Apakah sumber ini dapat membuat pengguna tertentu tersisih, misalnya tarif atau syarat dokumen kependudukan?
Keberlanjutan	Apakah sumber ini masih ada lima tahun lagi?

6.2 Peta Sumber Pembiayaan

Tabel 6.1 Sumber pembiayaan CBC

Sumber	Yang dibiayai	Syarat utama	Prediktabilitas
Dana publik			
JKN kapitasi	Seluruh layanan nonspesialistik bagi peserta terdaftar; dibayar per peserta per bulan	Klinik pratama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (Bab 7)	Tinggi
JKN non-kapitasi	Layanan tertentu di luar kapitasi, misalnya beberapa skrining	Sama dengan di atas	Sedang
Komoditas program pemerintah	ARV, reagen, dan komoditas lain (in-kind)	Terdaftar sebagai layanan HIV dan melapor ke SIHA	Tinggi
APBD melalui SPM kesehatan	Pelayanan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV, yang dapat diberikan di fasilitas pemerintah maupun swasta [30]	Masuk perencanaan Dinas Kesehatan	Sedang
Swakelola tipe III	Kegiatan yang dikontrak pemerintah daerah, misalnya penjangkauan, pendampingan, tes berbasis komunitas [14]	Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum; masuk rencana pengadaan perangkat daerah (Bab 7)	Sedang
Hibah daerah	Kegiatan organisasi masyarakat sesuai prioritas daerah [31]	Proposal sebelum penyusunan anggaran; persyaratan sesuai peraturan kepala daerah	Rendah–sedang
Dana nonpemerintah			
Pendapatan layanan	Tarif umum, tarif bertingkat, layanan prabayar komunitas, layanan non-HIV	Mematuhi guardrail akses (Bab 8)	Sedang

Sumber	Yang dibiayai	Syarat utama	Prediktabilitas
CSR perusahaan	Peralatan, renovasi, program tertentu; perseroan di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan [32]	Proposal dan laporan dampak	Rendah
Zakat, infak, sedekah	Bantuan biaya bagi pengguna tidak mampu melalui lembaga amil zakat [33]	Kerja sama dengan Baznas atau lembaga amil zakat	Rendah–sedang
Filantropi dan donasi individu	Kebutuhan yang tidak dibiayai sumber lain	Kampanye, transparansi penggunaan dana	Rendah
Donor internasional	Masa transisi; inovasi	Sesuai ketentuan donor	Menurun

JKN: memahami kapitasi

Kapitasi dibayar per peserta terdaftar per bulan, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan. Standar tarif kapitasi untuk klinik pratama adalah Rp9.000–16.000 per peserta per bulan, dan besarannya dipengaruhi antara lain rasio dokter terhadap peserta dan ketersediaan dokter gigi [34,35]. Pembayaran juga disesuaikan dengan capaian kinerja fasilitas setiap bulan (kapitasi berbasis kinerja) [35].

Contoh: klinik dengan 2.000 peserta terdaftar dan tarif Rp12.000 menerima sekitar Rp24.000.000 per bulan bila capaian kinerjanya penuh. Perlu diingat, kapitasi harus menutup **seluruh** layanan tingkat pertama bagi 2.000 peserta tersebut, bukan hanya pengguna layanan HIV. Karena itu, klinik perlu menarik peserta dari komunitas dan masyarakat sekitar, serta menghitung apakah biayanya tertutup.

> **Layanan HIV dalam JKN**
>
> ARV disediakan pemerintah, sedangkan pemeriksaan diagnosis dan layanan terkait dibiayai BPJS Kesehatan bagi peserta JKN [20]. Komponen yang sudah dibiayai program tidak boleh diklaim lagi ke JKN (lihat 6.4). Rincian layanan HIV yang masuk kapitasi dan non-kapitasi dikonfirmasi bersama BPJS Kesehatan setempat saat kredensialing.

Pendapatan layanan dan tarif

Tarif dapat menjadi sumber pendapatan, tetapi juga hambatan akses yang paling cepat terasa. Prinsipnya: **layanan inti HIV tidak dibebankan kepada pengguna yang tidak mampu**, dan tarif hanya diterapkan dengan kebijakan keringanan yang tidak mempermalukan. Rincian guardrail, termasuk layanan yang tidak boleh berbayar dan batas tarif, ada di Bab 8.

Pilihan pendapatan layanan yang lebih aman bagi akses antara lain layanan umum bagi masyarakat sekitar, layanan kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan berbayar bagi yang mampu, serta paket prabayar sukarela bagi komunitas dengan harga terjangkau. Pendapatan dari layanan ini dipakai untuk **subsidi silang** bagi pengguna yang tidak mampu.

Model bisnis sosial

Sebagian CBC ingin berkembang menjadi usaha sosial: klinik yang menghasilkan surplus dari layanan bagi yang mampu, lalu menggunakannya untuk menjaga misi sosial. Model ini dapat berhasil bila tiga syarat terpenuhi: ada pasar yang mampu membayar di sekitar klinik, ada pemisahan jelas antara layanan berbayar dan layanan sosial dalam pencatatan, dan ada aturan tertulis bahwa surplus dipakai untuk misi sosial.

6.3 Menyusun Kombinasi per Tipe Klinik

Urutan yang dianjurkan untuk semua tipe adalah: (1) **amankan dana publik** yang paling besar dan stabil; (2) **pastikan komoditas program** tetap mengalir; (3) **isi celah** dengan pendapatan layanan dan filantropi tanpa melanggar guardrail akses; (4) **bangun cadangan**.

Tabel 6.2 Kombinasi pembiayaan menurut tipe klinik

Tipe	Tulang punggung	Pelengkap	Yang dihindari
Tipe 1 Terhubung dana publik	Kapitasi JKN dan kontrak swakelola	Non-kapitasi, layanan umum, filantropi untuk pengguna tanpa JKN	Pembiayaan ganda; ketergantungan pada satu kontrak daerah
Tipe 2 Mapan, belum terhubung	Persiapan kredensialing JKN dan proposal swakelola; sementara itu donor dan pendapatan layanan	CSR untuk investasi yang dibutuhkan kredensialing; hibah daerah	Menunda kredensialing sampai donor berakhir
Tipe 3 Rentan finansial	Komoditas program dan dana daerah untuk fungsi prioritas	Filantropi, zakat untuk pengguna tidak mampu, efisiensi biaya	Menaikkan tarif untuk menutup kesenjangan
Tipe 4 Belum berizin mandiri	Kontrak swakelola untuk layanan komunitas; layanan klinis oleh puskesmas mitra	Hibah daerah, CSR	Membangun klinik tanpa rencana pembiayaan lanjutan

Contoh 6.1 Kombinasi pembiayaan setelah donor berakhir (klinik fiktif di Bab 5)

Sumber	Per bulan	Keterangan
Kapitasi JKN (2.000 peserta × Rp12.000)	Rp24.000.000	Setelah kredensialing; dengan capaian kinerja penuh
Non-kapitasi JKN	Rp3.000.000	Layanan tertentu
Kontrak swakelola tipe III	Rp15.000.000	Penjangkauan dan pendampingan sebaya
Pendapatan layanan umum	Rp8.000.000	Subsidi silang
Filantropi dan zakat	Rp6.000.000	Bantuan biaya pengguna tidak mampu
Total pendapatan	**Rp56.000.000**	
Biaya tunai	**Rp64.000.000**	Dari Contoh 5.2
Selisih	**−Rp8.000.000**	Masih defisit; perlu ditutup (lihat penjelasan di bawah)

Angka fiktif untuk ilustrasi. Nilai kapitasi, kontrak, dan pendapatan sebenarnya bergantung pada wilayah dan kinerja klinik.

Kombinasi di atas masih menyisakan defisit Rp8.000.000 per bulan. Ada tiga cara menutupnya. **Pertama, menambah peserta JKN terdaftar.** Setiap tambahan 100 peserta menambah sekitar Rp1.200.000 per bulan, sehingga tambahan sekitar 700 peserta (total 2.700) menutup defisit. Inilah titik impas klinik dalam jumlah peserta, dengan catatan tambahan peserta juga menambah biaya variabel bila mereka berkunjung, sehingga angka ini perlu dihitung ulang dengan Simulator. **Kedua, efisiensi**, misalnya menata ulang pembagian tugas staf atau menegosiasikan ulang sewa. **Ketiga, menambah kontrak atau sumber lain** tanpa melanggar guardrail akses. Rencana transisi di Bab 9 memadukan ketiganya dengan linimasa yang realistis.

6.4 Mencegah Pembiayaan Ganda

Pembiayaan ganda terjadi bila satu layanan atau komponen biaya dibiayai lebih dari satu sumber. Contohnya, reagen dari program diklaim lagi ke JKN, atau honor staf yang dibayar donor

dimasukkan penuh ke anggaran kontrak swakelola. Pembiayaan ganda dapat berujung pada temuan audit, pengembalian dana, dan rusaknya kepercayaan mitra.

Cara mencegah pembiayaan ganda

- Gunakan matriks siapa membiayai apa (Contoh 5.3) dan perbarui setiap ada kontrak atau hibah baru.
- Catat pembagian waktu staf dan bagi honor sesuai porsi waktu, bukan mengklaim penuh ke beberapa sumber.
- Tandai komoditas program sebagai in-kind dan jangan memasukkannya ke klaim atau anggaran kontrak.
- Simpan bukti setiap pengeluaran dengan kode sumber dana.
- Konsultasikan dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan bila ragu apakah suatu layanan boleh diklaim.

6.5 Pengalaman CBC

Lima pelajaran dari tujuh CBC

- **Kerja sama BPJS membuka pendapatan rutin.** Satu-satunya klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (CBC A) juga memiliki kesiapan finansial yang mapan.
- **Biaya administrasi untuk semua pengguna memberatkan.** Satu klinik menetapkan biaya administrasi bagi seluruh pengunjung untuk menutup biaya pemeliharaan alat CD4 dan viral load. Pengelolanya mencatat bahwa biaya ini memberatkan pengguna yang kurang mampu.
- **Dana daerah belum banyak dijajaki.** Tiga dari tujuh klinik belum pernah menjajaki dukungan pemerintah daerah, CSR, atau donor dalam negeri. Dua di antaranya adalah klinik dengan kesiapan finansial terendah.
- **Minat pada usaha sosial dan prabayar komunitas.** Satu klinik ingin mengembangkan model usaha sosial dengan subsidi silang, dan klinik lain mengusulkan layanan prabayar berbasis komunitas dengan harga terjangkau.
- **Keberlanjutan berarti menjadi bagian dari sistem lokal.** Klinik yang belum berizin mandiri melihat integrasi ke ekosistem layanan daerah sebagai kunci, bukan sekadar mencari dana pengganti.

Langkah berikutnya

- Pilih sumber dana prioritas dengan matriks di Lampiran 9.
- Tipe 1 dan Tipe 2: lanjutkan ke Bab 7 untuk langkah kredensialing JKN dan kontrak pemerintah.
- Periksa setiap rencana tarif terhadap guardrail akses di Bab 8.

Bab 7 Kredensialing JKN dan Kontrak Pemerintah

Pokok bab ini

- Langkah menjadi FKTP mitra BPJS Kesehatan dan menarik peserta terdaftar
- Cara memaksimalkan pendapatan JKN tanpa pembiayaan ganda
- Langkah swakelola tipe III dan cara masuk ke siklus anggaran daerah
- Hibah daerah dan advokasi anggaran

Bab ini menjawab kesenjangan terbesar dalam data tujuh CBC. Kerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah butir dengan skor terendah (1,49), pemahaman tentang syarat menerima dana publik berada di urutan kedua terendah (2,02), dan kemampuan menjelaskan langkah kredensialing serta swakelola menjadi kebutuhan pelatihan nomor satu (1,73 dari 4). Bab ini disusun sebagai panduan langkah demi langkah yang dapat langsung diikuti.

7.1 Menjadi FKTP Mitra BPJS Kesehatan

Siapa yang dapat bekerja sama

Fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui perjanjian tertulis [13]. Klinik pratama termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama [26]. Klinik berizin klinik utama perlu menempuh salah satu pilihan di Bab 3.3 terlebih dahulu.

Apa yang dinilai

BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing dengan empat kriteria teknis: sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. Proses ini melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan [36].

Tabel 7.1 Kriteria kredensialing dan persiapan CBC

Kriteria	Yang biasanya dinilai	Persiapan CBC
Sumber daya manusia	Dokter penanggung jawab, jumlah dokter dan tenaga kesehatan dibandingkan jam layanan, kelengkapan STR dan SIP	Pastikan rasio dokter memadai untuk jumlah peserta yang ditargetkan; lengkapi SIP semua tenaga
Sarana dan prasarana	Ruang pendaftaran, ruang tunggu, ruang periksa, peralatan medis dasar, laboratorium sederhana atau jejaring, ruang farmasi atau jejaring apotek	Perjanjian tertulis dengan laboratorium dan apotek bila tidak tersedia di klinik
Lingkup pelayanan	Kemampuan memberikan pelayanan tingkat pertama yang lengkap, termasuk promotif dan preventif	Tunjukkan bahwa klinik melayani masyarakat umum, bukan hanya layanan HIV
Komitmen pelayanan	Jam layanan, kesediaan memakai aplikasi BPJS dan rekam medis elektronik, komitmen mutu	Tunjukkan jam layanan panjang (termasuk sore dan malam) sebagai nilai tambah

Langkah kredensialing

Tabel 7.2 Langkah dari persiapan sampai perjanjian kerja sama

Langkah	Kegiatan	Keterangan
1	Konsultasi awal ke kantor cabang BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan	Tanyakan jadwal penerimaan kredensialing, kebutuhan FKTP di wilayah, dan dokumen terbaru

Langkah	Kegiatan	Keterangan
2	Lengkapi dokumen administrasi	Izin operasional klinik pratama, NPWP badan, SIP seluruh tenaga, perjanjian dengan jejaring (laboratorium, apotek) [37]
3	Siapkan sistem	Komputer dan internet, kesiapan memakai aplikasi BPJS, RME terhubung SATUSEHAT [37]
4	Ajukan permohonan dan unggah dokumen	Melalui kanal yang ditetapkan BPJS Kesehatan
5	Verifikasi dokumen dan visitasi lapangan	Tim menilai kesesuaian dokumen dengan kondisi nyata memakai formulir standar
6	Penilaian dan keputusan	Klinik yang memenuhi nilai ambang dinyatakan lulus kredensialing
7	Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS)	Baca ketentuan kapitasi, kapitasi berbasis kinerja, non-kapitasi, dan sanksi dengan teliti

Perhatian

Penerimaan FKTP baru mempertimbangkan kebutuhan fasilitas di wilayah. Di wilayah yang dinilai sudah cukup FKTP, peluang diterima dapat lebih kecil. Karena itu, mulailah dengan konsultasi awal (langkah 1) dan siapkan argumen tentang kebutuhan populasi yang dilayani CBC, misalnya data populasi kunci yang belum terjangkau dan jam layanan malam yang tidak tersedia di fasilitas lain.

Menarik peserta terdaftar

Kapitasi bergantung pada jumlah peserta yang memilih klinik sebagai FKTP. Peserta umumnya dapat pindah FKTP setelah terdaftar minimal tiga bulan di FKTP sebelumnya, kecuali karena pindah domisili atau pindah tempat kerja [38]. Strategi menarik peserta:

- **Komunitas lebih dulu.** Ajak pengguna yang sudah memiliki JKN memindahkan FKTP ke klinik, dengan pendampingan dari pendamping sebaya. Jangan memaksa. Pemindahan FKTP adalah hak dan pilihan pengguna.
- **Bantu kepesertaan.** Dampingi pengguna yang belum memiliki JKN untuk mendaftar, termasuk melalui jalur penerima bantuan iuran bagi yang memenuhi kriteria.
- **Layani masyarakat sekitar.** Kapitasi yang sehat membutuhkan peserta dari masyarakat umum, bukan hanya komunitas.
- **Jaga mutu dan keramahan.** Peserta yang puas akan tetap terdaftar dan mengajak orang lain.

7.2 Memaksimalkan Pendapatan JKN

Komponen	Cara memaksimalkan	Perhatian
Kapitasi	Tambah peserta terdaftar; jaga rasio dokter terhadap peserta sesuai ketentuan	Tarif dipengaruhi rasio dokter dan ketersediaan dokter gigi [35]
Kapitasi berbasis kinerja	Pantau indikator kinerja bulanan yang ditetapkan BPJS Kesehatan, misalnya kontak dengan peserta dan rujukan yang sesuai indikasi	Indikator dapat berubah; periksa ketentuan terbaru di kantor cabang
Non-kapitasi	Catat dan ajukan klaim layanan yang dibayar di luar kapitasi tepat waktu	Jangan mengklaim komponen yang sudah dibiayai program (Bab 6.4)
Pencatatan	Isi aplikasi BPJS dan RME secara lengkap dan tepat waktu	Pencatatan yang buruk menurunkan capaian kinerja dan nilai klaim

Kapitasi dibayar per peserta, bukan per kunjungan. Pengelola perlu memantau rasio antara biaya pelayanan peserta JKN dan pendapatan kapitasi setiap bulan dengan perhitungan di Bab 5, agar klinik tidak merugi karena peserta dengan kebutuhan layanan yang tinggi.

7.3 Swakelola Tipe III

Swakelola tipe III adalah cara pemerintah daerah membeli layanan dari organisasi kemasyarakatan. Kegiatan direncanakan dan diawasi perangkat daerah, misalnya Dinas Kesehatan, dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan berdasarkan kontrak antara pejabat pembuat komitmen dan pimpinan organisasi [14,39]. Mekanisme ini sejalan dengan dorongan global untuk memasukkan layanan yang dipimpin komunitas ke dalam kontrak sosial [3].

Kegiatan CBC yang cocok untuk swakelola

- Penjangkauan dan tes HIV berbasis komunitas bagi populasi kunci
- Pendampingan ODHIV baru dan pelacakan pengguna yang putus berobat
- Edukasi dan pencegahan, termasuk distribusi kondom dan pelicin
- Dukungan pencapaian SPM pelayanan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV [30]
- Pemantauan layanan berbasis komunitas

Tahapan

Peraturan LKPP membagi swakelola ke dalam tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima hasil pekerjaan. Perangkat daerah membentuk tim persiapan dan tim pengawas, sedangkan pimpinan organisasi pelaksana menetapkan tim pelaksana [39].

Tabel 7.3 Tahapan swakelola tipe III dan peran CBC

Tahap	Yang dilakukan perangkat daerah	Yang dilakukan CBC
Perencanaan	Menetapkan kegiatan yang diswakelolakan dan anggarannya dalam rencana kerja dan rencana pengadaan	Mengusulkan kegiatan, sasaran, dan biaya sejak siklus perencanaan (lihat kalender di bawah)
Persiapan	Menyusun kerangka acuan kerja, rencana anggaran biaya, jadwal; menilai kemampuan dan menetapkan organisasi pelaksana	Menyiapkan profil organisasi, legalitas, pengalaman, rencana kegiatan, dan rincian biaya berbasis costing
Pelaksanaan	Menandatangani kontrak; membayar sesuai ketentuan kontrak	Membentuk tim pelaksana; melaksanakan kegiatan; mencatat dan melaporkan kemajuan dan penyerapan anggaran
Pengawasan	Memantau kemajuan fisik dan keuangan	Menyediakan data dan bukti kegiatan; menjaga kerahasiaan data pengguna
Serah terima	Menerima hasil pekerjaan	Menyerahkan laporan akhir dan pertanggungjawaban keuangan

Syarat organisasi pelaksana

Persyaratan rinci organisasi kemasyarakatan pelaksana, penilaian kemampuan, dan model dokumen swakelola diatur dalam lampiran Peraturan LKPP tentang Pedoman Swakelola [39]. Pada praktiknya, perangkat daerah umumnya memeriksa legalitas badan hukum, kesesuaian bidang kegiatan dengan anggaran dasar, kepengurusan, NPWP, pengalaman, serta kemampuan teknis dan administrasi. Konfirmasikan daftar syarat dengan Dinas Kesehatan dan unit pengadaan daerah setempat.

Masuk ke siklus anggaran daerah

Usulan swakelola dan hibah harus masuk dokumen perencanaan daerah sebelum anggaran disusun. Usulan yang datang setelah anggaran ditetapkan hampir pasti harus menunggu tahun berikutnya.

Tabel 7.4 Kalender perencanaan dan penganggaran daerah (untuk anggaran tahun berikutnya)

Waktu (perkiraan)	Tahap daerah	Yang dilakukan CBC
Januari–Maret	Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari kelurahan sampai kabupaten/kota	Hadir dan mengusulkan kegiatan; kirim data kebutuhan layanan kepada Dinas Kesehatan
Maret–Juni	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah	Pastikan kegiatan masuk rencana kerja Dinas Kesehatan; ajukan proposal hibah
Juli–Agustus	Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	Advokasi bersama jaringan komunitas agar plafon kegiatan HIV terjaga
September–November	Rencana kerja dan anggaran perangkat daerah; pembahasan dan penetapan APBD	Pantau pembahasan; siapkan kerangka acuan dan rencana biaya rinci
Januari tahun berjalan	Pelaksanaan anggaran; pengumuman rencana pengadaan	Pantau rencana umum pengadaan; siapkan dokumen untuk penilaian kemampuan

Tahapan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah [31,40]. Jadwal persis dapat berbeda antardaerah.

> **Contoh dari lapangan**
>
> Hubungan dengan Dinas Kesehatan adalah aset terbesar tujuh CBC: komunikasi rutin dengan Dinkes mendapat skor rata-rata tertinggi (3,71). Namun hanya empat klinik yang pernah menjajaki dukungan pemerintah daerah atau sumber dalam negeri lainnya. Hubungan baik ini perlu diubah menjadi usulan anggaran yang konkret.

7.4 Hibah Daerah dan Mekanisme Lain

Hibah daerah adalah pemberian dana dari pemerintah daerah kepada organisasi masyarakat untuk kegiatan yang mendukung urusan pemerintahan daerah [31,40]. Berbeda dengan swakelola, hibah tidak membeli layanan tertentu dengan kontrak pengadaan, melainkan mendukung kegiatan yang diusulkan organisasi melalui naskah perjanjian hibah.

Aspek	Swakelola tipe III	Hibah daerah
Sifat	Pemerintah membeli layanan sesuai kerangka acuan	Pemerintah mendukung kegiatan yang diusulkan organisasi
Dasar	Kontrak dengan pejabat pembuat komitmen	Naskah perjanjian hibah daerah
Kesinambungan	Dapat diulang setiap tahun bila masuk rencana kerja	Umumnya tidak boleh diberikan terus-menerus kepada penerima yang sama, bergantung peraturan daerah
Cocok untuk	Layanan rutin: penjangkauan, pendampingan, tes komunitas	Investasi atau kegiatan khusus: renovasi, peralatan, pelatihan

7.5 Advokasi Anggaran

Pengambil keputusan membutuhkan tiga hal: **data**, **biaya**, dan **dukungan**. Siapkan ketiganya sebelum bertemu Dinas Kesehatan, Bappeda, atau DPRD.

1. **Data layanan dan dampak.** Jumlah orang yang dites, ditemukan positif, dan mulai ARV di klinik; kontribusi klinik terhadap capaian SPM dan target daerah.
2. **Biaya yang masuk akal.** Biaya per orang yang dijangkau atau didampingi dari perhitungan di Bab 5, dibandingkan dengan biaya bila layanan itu tidak tersedia.
3. **Dukungan komunitas dan mitra.** Surat dukungan jaringan komunitas, puskesmas mitra, dan tokoh masyarakat; kehadiran komunitas dalam musrenbang dan forum anggaran.
4. **Usulan yang spesifik.** Kegiatan, sasaran, nilai anggaran, dan mekanisme (swakelola atau hibah) yang jelas, bukan permintaan umum "dukungan untuk klinik".

Langkah berikutnya

- Gunakan daftar periksa kredensialing (Lampiran 11) dan daftar periksa swakelola beserta kalender anggaran (Lampiran 12).
- Susun kerangka acuan swakelola dengan templat di Lampiran 13.
- Sebelum mengubah cara pembiayaan, periksa guardrail akses di Bab 8.

Bab 8 Menjaga Akses, Mutu, Kerahasiaan, dan Peran Komunitas

Pokok bab ini

- Nilai CBC yang harus dijaga selama transisi
- Enam guardrail akses yang berlaku untuk setiap keputusan pembiayaan
- Kerahasiaan data dalam rekam medis, JKN, dan kontrak
- Peran komunitas, komunikasi perubahan, dan syarat pengalihan fungsi

Keberlanjutan tidak ada artinya bila pengguna yang paling rentan berhenti datang. Bab ini berisi syarat yang harus dipenuhi oleh setiap rencana keberlanjutan, termasuk tarif, kerja sama JKN, kontrak, dan pengalihan fungsi. Bab ini juga menjelaskan peran komunitas dalam memastikan syarat itu dipatuhi.

8.1 Nilai CBC yang Harus Dijaga

Pengelola tujuh CBC menyebut nilai berikut sebagai alasan klinik mereka dipilih komunitas. Nilai inilah yang tidak boleh hilang ketika cara pembiayaan berubah.

Nilai	Wujudnya di klinik
Keramahan dan tanpa stigma	Petugas, termasuk dari komunitas, memahami kebutuhan waria, LSL, pekerja seks, penasun, dan ODHIV
Kerahasiaan	Pengguna yakin statusnya tidak akan diketahui orang lain
Jam layanan yang sesuai	Buka sampai sore dan malam hari bagi pengguna yang bekerja siang
Pendampingan sebaya	Pengguna didampingi sejak tes, mulai ARV, sampai patuh berobat
Layanan menyeluruh	Tes, ARV, PrEP, IMS, dan dukungan dalam satu tempat

Daftar ini akan dilengkapi dengan hasil FGD pengguna layanan, yang juga menetapkan layanan yang tidak boleh berbayar dan batas tarif yang masih wajar.

8.2 Enam Guardrail Akses

Guardrail adalah batas yang tidak boleh dilanggar oleh keputusan pembiayaan. Keenamnya berlaku untuk semua tipe klinik.

Tabel 8.1 Guardrail akses CBC

No	Guardrail	Penerapan
1	**Layanan inti HIV tidak dibebankan kepada pengguna yang tidak mampu**	Tes HIV dan konseling, ARV, dan pendampingan bagi pengguna tidak mampu tetap tanpa biaya. ARV disediakan pemerintah dan tidak boleh dijual [20]. Strategi AIDS Global juga meminta penghapusan biaya pengguna untuk layanan esensial [3].
2	**Tidak ada penolakan layanan**	Tidak ada pengguna yang ditolak karena tidak mampu membayar, tidak memiliki JKN, atau tidak membawa dokumen kependudukan.
3	**Keringanan yang tidak mempermalukan**	Kriteria keringanan sederhana, dinilai secara tertutup, misalnya oleh pendamping sebaya, tanpa mewajibkan surat keterangan tidak mampu untuk memulai layanan.

No	Guardrail	Penerapan
4	**Batas tarif disepakati bersama komunitas**	Tarif untuk layanan berbayar ditetapkan dengan masukan pengguna, diumumkan secara terbuka, dan ditinjau secara berkala.
5	**Dampak dipantau**	Setiap perubahan tarif atau model layanan diikuti pemantauan bulanan terhadap jumlah kunjungan per populasi, pengguna yang putus berobat, dan pengaduan.
6	**Perubahan dibahas lebih dulu**	Perubahan yang memengaruhi akses dibahas dengan perwakilan komunitas dan diumumkan kepada pengguna sebelum diberlakukan.

Kapan perubahan harus ditinjau ulang

Tinjau ulang dan bila perlu batalkan perubahan bila setelah diberlakukan terjadi salah satu hal berikut: kunjungan populasi kunci tertentu turun berarti dibandingkan rata-rata tiga bulan sebelumnya, jumlah pengguna yang putus berobat meningkat, atau muncul pengaduan berulang tentang biaya. Ambang penurunan yang memicu peninjauan ditetapkan bersama komunitas.

Contoh dari lapangan

Satu CBC menetapkan biaya administrasi bagi seluruh pengunjung untuk menutup biaya operasional seperti pemeliharaan alat CD4 dan viral load. Pengelolanya sendiri mencatat bahwa biaya ini memberatkan pengguna yang kurang mampu. Sebanyak empat dari tujuh klinik memiliki skor di bawah 2,50 untuk kebijakan keringanan biaya bagi pengguna tidak mampu.

8.3 Kerahasiaan dan Pelindungan Data

Data kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik dan wajib dilindungi secara khusus [10]. Hasil pemeriksaan HIV wajib dirahasiakan dan registrasi pasien HIV harus dijaga kerahasiaannya [2]. Perubahan cara pembiayaan membuka titik risiko baru yang perlu diantisipasi.

Tabel 8.2 Titik risiko kerahasiaan dan langkah pengamanan

Titik risiko	Langkah pengamanan
Rekam medis elektronik	Hak akses berdasarkan peran; kata sandi kuat; catatan akses; tidak membuka rekam medis di layar yang terlihat pengguna lain [15]
Klaim dan aplikasi JKN	Pahami data apa yang dikirim ke BPJS Kesehatan; jelaskan kepada pengguna; konfirmasikan perlindungan data diagnosis HIV dengan BPJS setempat
Laporan kontrak swakelola dan hibah	Laporkan data agregat; jangan menyerahkan nama atau identitas pengguna kepada perangkat daerah atau mitra
Kerja sama dengan mitra swasta dan CSR	Larangan memakai foto atau cerita pengguna tanpa persetujuan tertulis; tidak membuka lokasi atau identitas
Pendampingan dan komunikasi	Komunikasi lewat pesan pribadi dengan persetujuan; hindari grup yang anggotanya tidak saling mengenal
Staf dan relawan	Perjanjian kerahasiaan untuk semua staf dan relawan; pelatihan berkala

Mintalah persetujuan pengguna secara jelas sebelum data mereka dibagikan untuk keperluan apa pun di luar pelayanan, dan jelaskan hak mereka atas data tersebut.

8.4 Peran Komunitas Selama Transisi

Peran	Bentuk kegiatan
Pemantauan berbasis komunitas	Komunitas mengumpulkan data pengalaman pengguna secara rutin (waktu tunggu, biaya, sikap petugas, ketersediaan obat), membahasnya dengan klinik, dan memantau tindak lanjutnya. Strategi AIDS Global mendorong pemantauan yang dipimpin komunitas masuk ke kontrak sosial [3].
Mekanisme pengaduan	Saluran pengaduan yang aman dan anonim, misalnya nomor WhatsApp yang dikelola komunitas, kotak saran, atau pendamping sebaya, dengan batas waktu tanggapan.
Pendampingan pengguna JKN	Membantu pendaftaran JKN, termasuk jalur penerima bantuan iuran; menjelaskan cara memindahkan FKTP; mendampingi saat ada kendala layanan.
Advokasi anggaran	Hadir dalam musrenbang dan forum anggaran; menyampaikan kebutuhan komunitas kepada Dinkes, Bappeda, dan DPRD (Bab 7.5).
Penggalangan dukungan	Menggalang donasi, relawan, dan dukungan tokoh masyarakat.
Tata kelola	Duduk dalam badan pengawas atau forum keputusan klinik (Bab 2 dan 4).

Kerangka pemantauan berbasis komunitas tersedia di Lampiran 16.

8.5 Mengomunikasikan Perubahan kepada Pengguna

Perubahan yang tidak dijelaskan dengan baik dapat membuat pengguna berhenti datang, bahkan bila layanan sebenarnya tetap tersedia tanpa biaya. Rencanakan komunikasi sebelum perubahan berlaku.

Unsur	Panduan
Isi pesan	Apa yang berubah dan kapan; apa yang **tidak** berubah, misalnya ARV tetap tersedia dan kerahasiaan tetap terjaga; apa yang perlu dilakukan pengguna; ke mana bertanya
Bahasa	Sederhana, tidak menghakimi, menggunakan istilah yang akrab bagi komunitas
Saluran	Pertemuan sebaya, pesan pribadi melalui pendamping, WhatsApp, poster di ruang tunggu; hindari saluran yang membuka identitas
Penyampai	Pendamping sebaya dan tokoh komunitas yang dipercaya, didukung petugas klinik
Waktu	Minimal satu bulan sebelum perubahan; diulang saat perubahan berlaku dan sesudahnya
Umpan balik	Sediakan cara bagi pengguna menyampaikan kekhawatiran, lalu tindak lanjuti

> **Contoh dari lapangan**
>
> Satu pengelola CBC mengusulkan diskusi kelompok dengan komunitas untuk menyiapkan mereka bila pola layanan berubah. Tujuannya agar komunitas memahami bahwa perubahan terjadi karena kebijakan pembiayaan, bukan keputusan klinik untuk meninggalkan mereka. Contoh pesan tersedia di Lampiran 15.

8.6 Bila Fungsi Dialihkan ke Puskesmas

Sebagian fungsi CBC, misalnya layanan ARV lanjutan bagi pengguna yang stabil, dapat dialihkan ke puskesmas sebagai bagian dari rencana transisi. Pengalihan hanya dilakukan bila syarat berikut terpenuhi:

1. Puskesmas tujuan siap melayani dengan ramah, dibuktikan antara lain dengan petugas yang terlatih layanan bagi populasi kunci.
2. Jam layanan dan lokasi dapat diakses oleh pengguna yang dialihkan.
3. Ada rujukan yang jelas dan pendampingan sebaya selama masa peralihan.
4. Pengguna diajak bicara dan diberi pilihan, bukan dipindahkan tanpa persetujuan.
5. Kerahasiaan terjaga selama pemindahan data.
6. Ada pemantauan bersama untuk memastikan pengguna tidak putus berobat setelah dialihkan.

Langkah berikutnya

- Uji setiap rencana tarif dan perubahan model layanan dengan matriks guardrail di Lampiran 14.
- Masukkan rencana komunikasi dan pemantauan komunitas ke rencana transisi (Bab 9).

Bab 9 Transformasi dan Rencana Transisi Klinik

Pokok bab ini

- Tiga "jam" yang harus diikuti: linimasa donor, siklus anggaran daerah, dan waktu persiapan klinik
- Memetakan dan mengklasifikasi fungsi yang bergantung pada donor
- Enam jalur transformasi CBC
- Menyusun skenario, rencana transisi, dan manajemen risikonya

Bab ini adalah inti pedoman. Bab ini merangkai hasil bab-bab sebelumnya, yaitu tipe klinik (Bab 2), biaya dan kesenjangan pendanaan (Bab 5), kombinasi pembiayaan (Bab 6), langkah JKN dan kontrak (Bab 7), serta guardrail akses (Bab 8), menjadi satu rencana transisi yang bertahap dan realistis.

Contoh dari lapangan

Empat dari tujuh CBC belum memiliki rencana tertulis yang memadai untuk menghadapi berakhirnya dukungan donor (rata-rata skor 2,43). Kemampuan menyusun rencana transisi yang tetap menjaga akses pengguna tidak mampu juga rendah (2,42), dan tidak ada responden yang merasa mampu mengajarkannya. Pengelola meminta transisi dilakukan bertahap, disertai dukungan teknis, dan tidak diakhiri sebelum ada sumber pembiayaan pengganti.

9.1 Memahami Linimasa Transisi

Rencana transisi harus mengikuti tiga "jam" sekaligus.

Jam	Yang perlu diketahui	Implikasi
Jam donor	Dukungan Global Fund untuk HIV berada pada alokasi final GC9 (2029–2031) dan dijadwalkan berakhir setelah 2032 [4,5]. Kementerian Kesehatan memimpin transisi sejak Maret 2026 dan memisahkan kegiatan yang dapat segera dibiayai domestik dari yang perlu bertahap [5].	Dukungan dapat berkurang bertahap pada setiap siklus hibah. Jangan menunggu tahun terakhir.
Jam anggaran daerah	Usulan harus masuk perencanaan daerah sekitar satu tahun sebelum anggaran berjalan (Bab 7.3).	Kegiatan yang ingin dibiayai APBD tahun depan harus diusulkan awal tahun ini.
Jam klinik	Perubahan izin, akreditasi, kredensialing, dan penambahan peserta JKN membutuhkan waktu berbulan-bulan.	Langkah dengan waktu tunggu panjang dimulai paling awal.

Di tingkat global, negara-negara menyusun peta jalan keberlanjutan HIV dalam dua bagian: komitmen politik dan sasaran jangka panjang, lalu rencana aksi transisi yang dihitung biayanya lengkap dengan tonggak dan sasaran pembiayaan domestik. Hampir semua peta jalan berkomitmen membiayai respons yang dipimpin komunitas dengan dana publik dan memperluas mekanisme kontrak sosial [41]. Rencana transisi CBC sebaiknya disusun selaras dengan arah ini dan dengan peta jalan transisi nasional.

Tabel 9.1 Contoh linimasa mundur dari berakhirnya dukungan donor (T)

Waktu	Kegiatan kunci
T − 36 bulan	Swa-nilai, penentuan tipe, costing; klasifikasi fungsi; mulai perubahan izin bila perlu
T − 30 bulan	Usulan kegiatan masuk musrenbang dan rencana kerja Dinkes; persiapan akreditasi dan kredensialing
T − 24 bulan	Pengajuan kredensialing BPJS; proposal hibah atau CSR untuk investasi; mulai memindahkan honor staf kunci secara bertahap

Waktu	Kegiatan kunci
T − 18 bulan	Kontrak swakelola pertama berjalan; kampanye peserta JKN terdaftar; komunikasi awal kepada pengguna
T − 12 bulan	Evaluasi capaian pembiayaan non-donor; penyesuaian skenario; efisiensi
T − 6 bulan	Uji guardrail akses untuk semua perubahan; rencana komunikasi akhir; cadangan kas
T	Layanan inti berjalan tanpa dukungan donor; pemantauan bulanan intensif selama enam bulan pertama

9.2 Memetakan Fungsi yang Bergantung pada Donor

Langkah ini menjawab dua pertanyaan: fungsi apa yang akan terganggu bila donor berhenti, dan apa yang sebaiknya dilakukan terhadap setiap fungsi itu. Pendekatan bertahap ini sejalan dengan anjuran WHO untuk memprioritaskan layanan berdasarkan kontribusinya terhadap hasil kesehatan, sambil memantau risiko gangguan layanan [8].

1. **Inventaris fungsi.** Daftar semua fungsi klinik: layanan klinis, layanan komunitas, dan fungsi pendukung.
2. **Petakan sumber dananya.** Gunakan matriks siapa membiayai apa (Bab 5.4).
3. **Hitung biayanya.** Gunakan hasil costing (Bab 5.3).
4. **Nilai tingkat kekritisan.** Kritis bila berhentinya fungsi langsung mengancam kesehatan pengguna, misalnya putus ARV; penting bila mengurangi akses atau mutu secara berarti; pendukung bila dampaknya terbatas atau dapat digantikan.
5. **Tetapkan arah** setiap fungsi: pertahankan, integrasikan, efisienkan, atau hentikan.

Tabel 9.2 Empat arah untuk fungsi yang bergantung pada donor

Arah	Pengertian	Contoh
Pertahankan	Fungsi kritis yang khas CBC dan tidak tersedia di tempat lain; dicarikan sumber dana baru	Pendampingan ODHIV baru, layanan ramah waria, jam layanan malam
Integrasikan	Fungsi yang dapat dibiayai atau dijalankan melalui sistem yang ada	Layanan klinis peserta JKN dibiayai kapitasi; ARV lanjutan bagi pengguna stabil di puskesmas; pelaporan masuk RME
Efisienkan	Fungsi yang tetap perlu tetapi dapat dijalankan dengan biaya lebih rendah	Menggabungkan tugas administrasi; menegosiasikan ulang sewa; penjangkauan daring
Hentikan	Fungsi yang dampaknya kecil atau sudah dijalankan pihak lain dengan baik	Kegiatan yang tumpang tindih dengan program puskesmas

> **Perhatian**
>
> Setiap keputusan "integrasikan" atau "hentikan" yang memengaruhi pengguna harus lolos uji guardrail akses (Lampiran 14) dan memenuhi syarat pengalihan fungsi ke puskesmas (Bab 8.6).

Lembar klasifikasi fungsi tersedia di Lampiran 18.

9.3 Memilih Jalur Transformasi

Tabel 9.3 Enam jalur transformasi CBC

Jalur	Cocok untuk	Langkah utama	Risiko yang perlu dikelola
1. Klinik program menjadi FKTP JKN	Tipe 2 berizin klinik pratama	Akreditasi, kredensialing, kampanye peserta terdaftar (Bab 7)	Kapitasi belum menutup biaya pada tahun pertama
2. Klinik utama menambah atau beralih ke klinik pratama	Tipe 2 berizin klinik utama	Konsultasi Dinkes dan DPMPTSP; perubahan izin atau izin baru (Bab 3.3)	Biaya dan waktu perizinan; layanan spesialis yang dihentikan
3. Layanan jejaring menjadi mitra kontrak atau klinik pratama	Tipe 4	Perjanjian kerja sama dengan puskesmas dan swakelola; atau studi kelayakan klinik pratama (Bab 3)	Ketergantungan pada satu puskesmas; kesiapan standar perizinan
4. Menuju usaha sosial	Klinik dengan pasar yang mampu membayar di sekitarnya	Layanan umum dan berbayar untuk subsidi silang; pemisahan pencatatan (Bab 6.2)	Pergeseran misi; pengguna rentan tersisih
5. Integrasi fungsi klinis dengan kontrak komunitas	Klinik yang tidak dapat mempertahankan layanan klinis penuh	Layanan klinis dialihkan ke puskesmas; CBC dikontrak untuk penjangkauan dan pendampingan (Bab 7.3, 8.6)	Pengguna putus berobat saat pengalihan
6. Kemitraan atau penggabungan	Klinik kecil di wilayah yang sama	Berbagi layanan pendukung (keuangan, laboratorium, pelaporan) atau bergabung dengan klinik mitra	Kehilangan identitas komunitas; tata kelola gabungan

Satu klinik dapat menempuh lebih dari satu jalur, misalnya jalur 1 dan 4 sekaligus. Pilih jalur yang paling sesuai dengan tipe, konteks wilayah, dan kekuatan klinik, lalu tuangkan ke dalam rencana transisi.

9.4 Menyusun Skenario dan Proyeksi 36 Bulan

Gunakan Simulator Keberlanjutan CBC (lembar Skenario) untuk menyusun tiga skenario:

Skenario	Asumsi	Gunanya
Dasar	Langkah berjalan sesuai rencana: kredensialing lulus, kontrak swakelola diperoleh tahun kedua	Rencana utama
Pesimis	Kredensialing tertunda setahun, dana daerah terlambat cair, dukungan donor berkurang lebih cepat	Menentukan cadangan dan langkah darurat
Optimis	Peserta JKN tumbuh cepat, ada tambahan kontrak atau mitra	Menentukan investasi yang dapat dipercepat

Dari skenario pesimis, hitung **kebutuhan dana minimum**, yaitu biaya untuk fungsi berarah "pertahankan" dan "integrasikan" selama masa peralihan. Angka ini adalah batas bawah yang harus diamankan sebelum dukungan donor berakhir.

Contoh 9.1 Pergeseran komposisi pendanaan dalam skenario dasar (klinik fiktif)

Sumber	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Donor	70%	40%	5%
JKN (kapitasi dan non-kapitasi)	0%	25%	40%

Sumber	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
APBD (swakelola dan hibah)	0%	15%	25%
Pendapatan layanan	15%	12%	18%
Filantropi, CSR, zakat	15%	8%	12%
Total	**100%**	**100%**	**100%**

Angka fiktif untuk ilustrasi.

9.5 Menyusun Rencana Transisi

Rencana transisi yang baik cukup ringkas, misalnya 8–12 halaman, tetapi lengkap. Gunakan struktur berikut (templat di Lampiran 17):

Bagian	Isi	Sumber
1. Ringkasan dan tujuan	Kondisi yang ingin dicapai pada akhir transisi	–
2. Situasi awal	Hasil swa-nilai, tipe klinik, biaya, kesenjangan pendanaan, daya tahan kas	Bab 2, 5
3. Klasifikasi fungsi	Arah setiap fungsi dan alasannya	Bab 9.2
4. Jalur transformasi	Jalur yang dipilih	Bab 9.3
5. Target pembiayaan	Target per sumber per tahun dan kebutuhan dana minimum	Bab 6, 9.4
6. Rencana aksi	Kegiatan, tonggak, penanggung jawab, tenggat, anggaran	Bab 3, 4, 7
7. Akses dan komunikasi	Hasil uji guardrail, rencana komunikasi, peran komunitas	Bab 8
8. Risiko dan mitigasi	Daftar risiko dan langkah antisipasi	Bab 9.6
9. Pemantauan dan revisi	Indikator, jadwal tinjauan, siapa yang meninjau	Bab 10

Tabel 9.4 Contoh tonggak transisi

Tonggak	Target waktu	Bukti tercapai
Rencana transisi disetujui badan pengawas dan dibahas dengan komunitas	Bulan 2	Notulen dan daftar hadir
Usulan kegiatan masuk rencana kerja Dinkes	Bulan 6	Dokumen rencana kerja
Klinik lulus kredensialing BPJS Kesehatan	Bulan 12	PKS
Kontrak swakelola pertama ditandatangani	Bulan 14	Kontrak
50% honor staf kunci dibiayai sumber non-donor	Bulan 18	Laporan keuangan
Cadangan kas tiga bulan tercapai	Bulan 30	Laporan keuangan

Rencana transisi harus disetujui badan pengawas, dibahas bersama perwakilan komunitas, dan dikomunikasikan kepada staf. Contoh rencana transisi lengkap untuk klinik fiktif ada di Lampiran 19.

9.6 Manajemen Risiko Transisi

Tabel 9.5 Risiko umum transisi dan mitigasinya

Risiko	Tanda awal	Mitigasi
Dana daerah terlambat cair di awal tahun	Kontrak belum ditandatangani pada triwulan pertama	Cadangan kas; jadwal kegiatan yang mengikuti waktu pencairan; komunikasi dini dengan Dinkes
Kredensialing ditolak atau tertunda	Hasil konsultasi awal menunjukkan kuota FKTP penuh	Perkuat argumen kebutuhan populasi; perbaiki kekurangan; siapkan kontrak swakelola sebagai alternatif
Staf kunci keluar	Kontrak hampir berakhir tanpa kepastian	Rencana retensi (Lampiran 6); komunikasi rencana transisi kepada staf
Kekosongan reagen atau BMHP	Stok di bawah stok pengaman	Jalur pengadaan alternatif (Bab 4.5); dana cadangan untuk komoditas
Pengguna berhenti datang	Kunjungan populasi tertentu turun	Pemantauan berbasis komunitas; peninjauan ulang perubahan (Bab 8.2)
Temuan pembiayaan ganda	Matriks pembiayaan tidak diperbarui	Perbarui matriks setiap ada kontrak baru; audit internal
Perubahan kebijakan atau anggaran nasional	Pengumuman efisiensi anggaran	Advokasi melalui jaringan; diversifikasi sumber

Langkah berikutnya

- Isi Lampiran 18 (klasifikasi fungsi) lalu Lampiran 17 (rencana transisi).
- Uji rencana dengan matriks guardrail akses (Lampiran 14).
- Tetapkan indikator dan jadwal pemantauan dengan Bab 10.

Bab 10 Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran

Pokok bab ini

- Indikator keberlanjutan finansial, operasional, dan akses
- Siklus tinjauan bulanan sampai tahunan
- Peran pengelola program dalam mendukung CBC
- Berbagi pembelajaran antar-CBC

Rencana transisi perlu dipantau secara rutin agar klinik dapat mendeteksi masalah lebih awal dan menyesuaikan langkahnya. Pemantauan juga memberi bukti kinerja yang dibutuhkan untuk kontrak, kredensialing, dan advokasi anggaran.

10.1 Indikator Keberlanjutan

Tabel 10.1 Indikator keberlanjutan CBC

Indikator	Cara menghitung	Arah yang diharapkan	Frekuensi
Finansial			
Porsi pendapatan non-donor	Pendapatan non-donor ÷ total pendapatan	Naik sesuai target rencana transisi	Bulanan
Jumlah sumber pendapatan	Jumlah sumber dengan porsi ≥ 5%	Minimal tiga	Triwulanan
Daya tahan kas	Saldo kas ÷ kesenjangan bulanan	Naik	Bulanan
Cadangan kas	Saldo kas ÷ biaya tunai bulanan	Minimal tiga bulan	Bulanan
Biaya per layanan	Dari lembar costing	Stabil atau turun tanpa menurunkan mutu	Tahunan
Peserta JKN terdaftar	Jumlah peserta pada data BPJS	Naik menuju titik impas	Bulanan
Operasional			
Kekosongan stok	Jumlah hari layanan terhenti karena stok	Nol	Bulanan
Staf kunci dengan sumber honor stabil	Staf kunci yang dibayar sumber non-donor ÷ total staf kunci	Naik	Triwulanan
Ketepatan pelaporan SIHA	Laporan tepat waktu ÷ laporan wajib	100%	Bulanan
Skor swa-nilai	Kesiapan kelembagaan dan finansial	Naik ke tingkat mapan atau maju	Tahunan
Akses			
Kunjungan per populasi kunci	Jumlah kunjungan per kelompok	Tidak turun setelah perubahan	Bulanan
Pengguna dengan keringanan biaya	Pengguna yang mendapat keringanan ÷ pengguna yang dikenai tarif	Sesuai kebutuhan; dipantau bila turun tajam	Bulanan
ODHIV yang tetap berobat	ODHIV aktif ARV ÷ ODHIV yang memulai ARV	Naik	Triwulanan
Pengaduan dan tindak lanjut	Pengaduan yang ditindaklanjuti ÷ total pengaduan	100%	Triwulanan

Dasbor indikator dalam bentuk lembar satu halaman tersedia di Lampiran 20. Versi interaktifnya tersedia di e-learning.

10.2 Siklus Tinjauan

Siklus	Siapa	Yang ditinjau
Bulanan	Pimpinan klinik dan bagian keuangan	Dasbor indikator, arus kas, stok, kunjungan
Triwulanan	Badan pengawas bersama perwakilan komunitas	Kemajuan rencana transisi, hasil pemantauan berbasis komunitas, risiko
Enam bulanan	Badan pengawas, pimpinan, mitra	Revisi rencana transisi dan skenario
Tahunan	Seluruh tim inti	Swa-nilai ulang, costing ulang, rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya

10.3 Peran Pengelola Program

Keberlanjutan CBC tidak dapat dicapai klinik sendirian. Pengelola program dapat mendukung melalui peran berikut.

Pengelola	Peran yang dapat dijalankan
Kementerian Kesehatan	• Menegaskan posisi CBC dalam kebijakan dan peta jalan transisi • Menjaga kesinambungan komoditas program • Mendorong mekanisme kontrak sosial dan memantau keberlanjutan CBC secara nasional
Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota	• Mendampingi perizinan dan perubahan jenis klinik • Memasukkan layanan CBC ke rencana kerja, SPM, dan kontrak swakelola • Memfasilitasi jejaring rujukan dan pengalihan fungsi
BPJS Kesehatan	• Memberi kejelasan proses kredensialing bagi CBC • Menjaga kerahasiaan data diagnosis peserta
Yayasan Spiritia dan jaringan komunitas	• Pendampingan teknis costing, proposal, dan rencana transisi • Forum belajar antar-CBC • Pelatihan dan pemantauan berbasis komunitas

Peran ini akan dikonfirmasi melalui wawancara dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Yayasan Spiritia.

10.4 Berbagi Pembelajaran Antar-CBC

- **Forum CBC** berkala, daring atau tatap muka, untuk berbagi kemajuan dan hambatan transisi.
- **Mentoring sejawat.** Pasangkan klinik Tipe 1 dengan klinik Tipe 2–4 untuk berbagi pengalaman kredensialing, kontrak, dan pengelolaan kapitasi.
- **Dokumentasi praktik baik** dalam bentuk studi kasus singkat yang dapat dipakai di pelatihan dan e-learning, dengan izin klinik dan tanpa identitas pengguna.
- **Komunitas belajar di e-learning**, tempat alumni pelatihan berbagi lembar kerja dan pertanyaan.

> **Penutup**
>
> Keberlanjutan adalah proses, bukan tujuan sekali jadi. Lakukan swa-nilai setiap tahun, perbarui costing dan rencana transisi, dan libatkan komunitas di setiap langkah. Dengan begitu, CBC dapat terus menjadi pintu layanan yang dipercaya komunitas, apa pun perubahan sumber dananya.

Lampiran 1 Alat Swa-Nilai Kesiapan Keberlanjutan CBC

Alat ini menilai kesiapan klinik untuk mempertahankan layanan ketika dukungan dari sumber tertentu berkurang. Pengisian memerlukan sekitar 30 menit per penilai. Versi interaktif yang menghitung skor secara otomatis tersedia di e-learning.

Petunjuk

- Isi oleh 2–3 orang dengan peran berbeda, masing-masing secara terpisah.
- Centang satu kotak yang paling menggambarkan kondisi klinik **saat ini**, bukan rencana.

Skor	Arti	Penjelasan
1	Belum ada	Belum pernah dilakukan atau belum dimiliki
2	Mulai	Sudah dibicarakan atau dimulai, tetapi belum rutin atau belum tertulis
3	Sudah berjalan	Sudah rutin dilakukan, sebagian besar terdokumentasi
4	Sudah kuat	Rutin, terdokumentasi, dipantau, dan tetap berjalan meskipun ada pergantian staf
TT	Tidak tahu	Pilih hanya bila benar-benar tidak mengetahui kondisinya

Nama klinik: _____ *Peran penilai:* _____ *Tanggal:* _____

No	Pernyataan	1	2	3	4	TT
A. Tata kelola dan kepemimpinan						
A1	Klinik memiliki struktur organisasi tertulis dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas.	☐	☐	☐	☐	☐
A2	Pimpinan klinik secara aktif membahas keberlanjutan layanan setelah dukungan donor berakhir.	☐	☐	☐	☐	☐
A3	Ada badan atau pihak pengawas (pengurus yayasan, dewan, pemilik) yang meninjau kinerja dan keuangan klinik secara berkala.	☐	☐	☐	☐	☐
A4	Keputusan penting klinik (anggaran, tarif, layanan) diambil melalui mekanisme yang jelas dan tercatat.	☐	☐	☐	☐	☐
A5	Klinik memiliki SOP tertulis untuk layanan utama dan administrasi yang dipakai sehari-hari.	☐	☐	☐	☐	☐
B. Perencanaan strategis						
B1	Klinik memiliki rencana kerja minimal satu tahun yang dipantau secara rutin.	☐	☐	☐	☐	☐
B2	Klinik memiliki rencana tertulis untuk menghadapi berkurang atau berakhirnya dukungan donor.	☐	☐	☐	☐	☐
B3	Rencana klinik memuat target sumber pendapatan selain donor beserta langkah mencapainya.	☐	☐	☐	☐	☐
B4	Klinik mengetahui fungsi atau kegiatan mana yang paling berisiko berhenti bila donor keluar.	☐	☐	☐	☐	☐
C. Stabilitas pendanaan dan manajemen keuangan						
C1	Pendapatan klinik berasal dari lebih dari dua sumber yang berbeda.	☐	☐	☐	☐	☐
C2	Klinik membuat laporan keuangan bulanan yang memisahkan setiap sumber dana.	☐	☐	☐	☐	☐
C3	Laporan keuangan klinik pernah diaudit atau diperiksa pihak independen dalam dua tahun terakhir.	☐	☐	☐	☐	☐

No	Pernyataan	1	2	3	4	TT
C4	Klinik mengetahui biaya per jenis layanan utama (misalnya biaya per tes HIV atau per kunjungan ARV).	☐	☐	☐	☐	☐
C5	Klinik memiliki cadangan kas yang cukup untuk membiayai operasional minimal tiga bulan.	☐	☐	☐	☐	☐
D. Sumber daya manusia						
D1	Jumlah dan kompetensi staf memadai untuk menjalankan layanan inti tanpa tambahan staf dari donor.	☐	☐	☐	☐	☐
D2	Klinik memiliki rencana untuk mempertahankan staf kunci bila sumber gajinya berakhir.	☐	☐	☐	☐	☐
D3	Pergantian staf dalam setahun terakhir tidak mengganggu layanan secara berarti.	☐	☐	☐	☐	☐
D4	Pengetahuan kerja penting (prosedur, kontak mitra, sistem pelaporan) tidak hanya dikuasai satu orang.	☐	☐	☐	☐	☐
E. Sistem informasi dan pemantauan						
E1	Klinik mencatat volume layanan bulanan per jenis layanan secara rutin.	☐	☐	☐	☐	☐
E2	Klinik melaporkan data layanan ke sistem nasional (SIHA atau sistem lain yang ditetapkan) tepat waktu.	☐	☐	☐	☐	☐
E3	Data layanan dipakai untuk mengambil keputusan, misalnya perencanaan staf, stok, atau jadwal.	☐	☐	☐	☐	☐
E4	Sistem pencatatan klinik dapat tetap berjalan tanpa lisensi, perangkat, atau petugas yang dibiayai donor.	☐	☐	☐	☐	☐
F. Logistik dan rantai pasok						
F1	Klinik memiliki pencatatan stok obat, reagen, dan BMHP yang diperbarui secara rutin.	☐	☐	☐	☐	☐
F2	Dalam enam bulan terakhir klinik tidak mengalami kekosongan stok yang menghentikan layanan.	☐	☐	☐	☐	☐
F3	Klinik mengetahui jalur pengadaan komoditas bila suplai dari program atau donor berhenti.	☐	☐	☐	☐	☐
G. Kemitraan dan jejaring						
G1	Klinik memiliki kerja sama tertulis dengan puskesmas, rumah sakit, atau laboratorium rujukan.	☐	☐	☐	☐	☐
G2	Klinik menjalin komunikasi rutin dengan Dinas Kesehatan setempat.	☐	☐	☐	☐	☐
G3	Klinik pernah menjajaki atau menerima dukungan dari pemerintah daerah, CSR, atau donor dalam negeri.	☐	☐	☐	☐	☐
G4	Klinik terhubung dengan jaringan komunitas yang membantu penjangkauan dan pendampingan pengguna.	☐	☐	☐	☐	☐
H. Perizinan dan kepatuhan						
H1	Klinik memiliki izin operasional yang berlaku sesuai ketentuan.	☐	☐	☐	☐	☐
H2	Klinik sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau sedang memproses kredensialing.	☐	☐	☐	☐	☐
H3	Klinik memahami persyaratan untuk menerima dana publik (JKN, APBD, swakelola tipe III).	☐	☐	☐	☐	☐
I. Akses, mutu, dan keterlibatan komunitas						
I1	Klinik memiliki kebijakan tertulis tentang kerahasiaan data pengguna yang dipahami seluruh staf.	☐	☐	☐	☐	☐

No	Pernyataan	1	2	3	4	TT
I2	Klinik memiliki kebijakan pembebasan atau keringanan biaya bagi pengguna tidak mampu.	☐	☐	☐	☐	☐
I3	Masukan pengguna layanan atau komunitas dikumpulkan dan dipakai untuk memperbaiki layanan.	☐	☐	☐	☐	☐

Rekap skor

Domain	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3	Rata-rata	Tingkat
A. Tata kelola dan kepemimpinan					
B. Perencanaan strategis					
C. Stabilitas pendanaan dan manajemen keuangan					
D. Sumber daya manusia					
E. Sistem informasi dan pemantauan					
F. Logistik dan rantai pasok					
G. Kemitraan dan jejaring					
H. Perizinan dan kepatuhan					
I. Akses, mutu, dan keterlibatan komunitas					
Kesiapan kelembagaan (rata-rata A, B, D, E, F, G, H)					
Kesiapan finansial (domain C)					

Aturan penghitungan

- Skor domain adalah rata-rata butir dalam domain. Jawaban TT tidak dihitung tetapi dicatat.
- Domain dengan lebih dari separuh jawaban TT ditandai "data tidak cukup".
- Butir dengan selisih skor antarpenilai 1,5 poin atau lebih dibahas bersama.
- Domain I tidak dimasukkan ke skor kesiapan. Skor rendah pada domain I menjadi prioritas perbaikan sebelum perubahan tarif atau model layanan (Bab 8).
- Konversi tingkat: 1,00–1,75 merintis; 1,76–2,50 berkembang; 2,51–3,25 mapan; 3,26–4,00 maju.

Lampiran 2 Lembar Penentuan Tipe Klinik

Jawab pertanyaan berikut secara berurutan. Berhenti pada pertanyaan pertama yang menghasilkan tipe.

No	Pertanyaan	Jawaban	Hasil
1	Apakah klinik memiliki izin klinik yang masih berlaku atas nama badan hukum pemiliknya?	☐ Ya ☐ Tidak	Tidak → **Tipe 4**. Ya → lanjut ke pertanyaan 2.
2	Berapa skor kesiapan finansial (domain C) dari Lampiran 1? _____	☐ > 2,50 ☐ ≤ 2,50	≤ 2,50 → **Tipe 3**. > 2,50 → lanjut ke pertanyaan 3.
3	Apakah klinik sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan atau kontrak aktif dengan pemerintah daerah?	☐ Ya ☐ Tidak	Ya → **Tipe 1**. Tidak → **Tipe 2**.

Hasil	Isian
Tipe klinik	☐ Tipe 1 ☐ Tipe 2 ☐ Tipe 3 ☐ Tipe 4
Tingkat kesiapan kelembagaan	☐ Merintis ☐ Berkembang ☐ Mapan ☐ Maju
Tingkat kesiapan finansial	☐ Merintis ☐ Berkembang ☐ Mapan ☐ Maju
Tiga prioritas perbaikan	1. 2. 3.
Disepakati oleh	Nama dan peran: _____ *Tanggal:* _____

Lampiran 3 Daftar Periksa Perizinan Klinik Pratama

Gunakan daftar ini untuk menyiapkan permohonan izin melalui OSS. Rincian standar mengikuti lampiran Permenkes 11/2025; periksa versi terbaru di OSS atau Dinas Kesehatan.

	Dokumen atau persyaratan	Keterangan
A. Legalitas badan hukum		
☐	Akta pendirian dan perubahan terakhir	Notaris
☐	Surat keputusan pengesahan badan hukum	Kementerian Hukum
☐	NPWP badan hukum	Direktorat Jenderal Pajak
☐	Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI klinik	OSS
B. Persyaratan dasar		
☐	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)	OSS / pemerintah daerah
☐	Persetujuan lingkungan	Sesuai skala kegiatan
☐	Persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF)	Pemerintah daerah; bila menyewa, minta dari pemilik bangunan
☐	Bukti penguasaan lahan atau bangunan (sertifikat atau perjanjian sewa)	Perhatikan jangka waktu sewa
C. Dokumen klinik		
☐	Profil klinik: layanan, jam layanan, denah ruang	Disusun klinik
☐	Surat penetapan dokter penanggung jawab	Pimpinan badan hukum
☐	Swa-nilai pemenuhan standar	Format OSS
☐	Peraturan internal klinik	Disusun klinik
☐	Daftar obat dan BMHP	Disusun klinik
☐	Dokumen dan perjanjian pengelolaan limbah medis	Dengan pengolah atau pengangkut berizin
D. Sumber daya manusia		
☐	Daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan beserta STR	Sesuai jenis dan jumlah minimal dalam standar
☐	SIP setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan di klinik ini	Dinas Kesehatan / DPMPTSP
E. Setelah izin terbit		
☐	Registrasi rekam medis elektronik dan integrasi SATUSEHAT	Kementerian Kesehatan
☐	Akun SIHA dan registrasi sebagai layanan HIV	Dinas Kesehatan
☐	Rencana akreditasi dalam dua tahun	Lembaga penyelenggara akreditasi

Lampiran 4 Templat Studi Kelayakan Sederhana

Isi setiap bagian secara singkat. Studi kelayakan ini menjadi dasar rencana bisnis (4.2) dan proposal pendanaan.

Bagian	Pertanyaan yang dijawab	Isian
1. Kebutuhan wilayah	Berapa ODHIV dan populasi kunci di wilayah layanan? Berapa yang belum terjangkau? Layanan apa yang sudah ada dan apa kesenjangannya?	
2. Rancangan layanan	Layanan klinis dan komunitas apa yang akan diberikan? Jam layanan? Siapa sasaran utama dan sasaran umum?	
3. Lokasi dan sarana	Di mana lokasinya? Status lahan dan bangunan? Apakah memenuhi tata ruang, PBG, dan SLF? Apakah ruangnya cukup untuk menjaga privasi?	
4. SDM	Siapa dokter penanggung jawab? Berapa tenaga yang dibutuhkan? Dari mana honornya?	
5. Perkiraan volume	Berapa kunjungan per bulan pada tahun 1, 2, dan 3? Berapa calon peserta JKN terdaftar?	
6. Biaya awal	Renovasi, peralatan, perizinan, sistem informasi, modal kerja tiga bulan	
7. Biaya operasional	Honor, sewa, utilitas, komoditas yang dibeli sendiri, administrasi (per bulan)	
8. Sumber dana	Sumber untuk tahun 1–3 dan rencana tahun 4 tanpa hibah: JKN, APBD/swakelola, pendapatan layanan, filantropi	
9. Risiko	Apa risiko terbesar dan bagaimana mitigasinya?	
10. Kesimpulan	Layak, layak dengan syarat, atau belum layak? Apa syaratnya?	

Lampiran 5 Daftar Periksa Kapasitas Organisasi

Daftar ini merinci praktik di Bab 4. Isi bersama tim inti klinik dan lampirkan bukti untuk setiap jawaban "Ya".

No	Praktik	Ya	Sebagian	Belum	Bukti / catatan
Tata kelola					
1	Bagan struktur dan uraian tugas tertulis dan terbaru	☐	☐	☐	
2	Rapat badan pengawas minimal triwulanan dengan notulen	☐	☐	☐	
3	Ada perwakilan komunitas atau ODHIV dalam forum keputusan	☐	☐	☐	
4	Kebijakan konflik kepentingan	☐	☐	☐	
5	Peraturan internal klinik dan SOP layanan utama diperbarui dalam dua tahun terakhir	☐	☐	☐	
Perencanaan					
6	Rencana strategis 3–5 tahun	☐	☐	☐	
7	Rencana bisnis dengan proyeksi tiga tahun	☐	☐	☐	
8	Rencana kerja dan anggaran tahunan per sumber dana	☐	☐	☐	
9	Keberlanjutan menjadi agenda tetap rapat pengawas	☐	☐	☐	
SDM					
10	Peta staf, sumber honor, dan tanggal berakhirnya	☐	☐	☐	
11	Catatan pembagian waktu staf antarlayanan	☐	☐	☐	
12	Rencana retensi staf kunci (Lampiran 6)	☐	☐	☐	
13	Minimal dua orang terlatih untuk setiap tugas kritis	☐	☐	☐	
14	Pemantauan masa berlaku STR dan SIP	☐	☐	☐	
Sistem informasi					
15	Volume layanan bulanan per jenis layanan dan kelompok pengguna	☐	☐	☐	
16	Pelaporan SIHA tepat waktu dalam enam bulan terakhir	☐	☐	☐	
17	RME terhubung dengan SATUSEHAT	☐	☐	☐	
18	Sistem pencatatan tidak bergantung pada lisensi atau petugas yang dibiayai donor	☐	☐	☐	
19	Akses data dibatasi berdasarkan peran	☐	☐	☐	
Logistik					
20	Kartu stok atau sistem stok diperbarui setiap transaksi	☐	☐	☐	
21	Stok minimal dan stok pengaman ditetapkan	☐	☐	☐	

No	Praktik	Ya	Sebagian	Belum	Bukti / catatan
22	Daftar komoditas yang dibiayai donor dan jalur pengadaan alternatifnya	☐	☐	☐	
23	Nilai in-kind komoditas program dicatat	☐	☐	☐	
Kemitraan					
24	Perjanjian rujukan tertulis dengan puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium	☐	☐	☐	
25	Pertemuan rutin dengan Dinas Kesehatan	☐	☐	☐	
26	Daftar calon mitra swasta dan filantropi	☐	☐	☐	
Keuangan dasar					
27	Pencatatan per sumber dana dan terpisah dari program lain	☐	☐	☐	
28	Laporan keuangan bulanan	☐	☐	☐	
29	Otorisasi ganda dan pemisahan fungsi	☐	☐	☐	
30	Audit atau pemeriksaan independen dalam dua tahun terakhir	☐	☐	☐	
31	Daftar risiko dan mitigasinya	☐	☐	☐	

Lampiran 6 Templat Rencana Retensi Staf Kunci

Isi satu baris untuk setiap posisi kunci. Baris pertama adalah contoh.

Posisi	Sumber honor saat ini	Berakhir	Dampak bila kosong	Sumber pengganti	Langkah dan tenggat	PJ
Petugas pelaporan SIHA	*Program donor*	*Des 2027*	*Pelaporan terhenti; alokasi komoditas terganggu*	*50% jasa pelayanan JKN, 50% kontrak swakelola*	*Latih staf kedua (Mar 2027); masukkan ke proposal swakelola (Mei 2027)*	*Manajer klinik*

Lampiran 7 Lembar Kerja Costing per Layanan

Isi dengan rata-rata bulanan dari enam sampai dua belas bulan terakhir. Contoh pengisian ada di Bab 5.

Bagian A. Biaya tetap bulanan

Komponen	Dibayar klinik	Dibayar donor	In-kind (nilai)	Total
Honor dan gaji (rinci per posisi)				
Sewa bangunan				
Listrik, air, internet				
Penyusutan peralatan				
Sistem informasi dan lisensi				
Administrasi umum				
Total biaya tetap (F)				

Bagian B. Biaya per layanan

Layanan	Volume (V)	Bobot (W)	Unit tertimbang (V×W)	Biaya tetap per layanan (F ÷ ΣVW × W)	Biaya variabel per kunjungan	Biaya per layanan
Tes HIV		1,0				
Kunjungan ARV						
PrEP						
IMS						
Hepatitis						
Layanan umum						
Total			ΣVW =			

Bagian C. Ringkasan

Indikator	Nilai
Biaya tunai bulanan (biaya tetap yang dibayar klinik dan donor + biaya variabel)	
Biaya penuh bulanan (biaya tunai + in-kind)	
Pendapatan non-donor bulanan	
Kesenjangan pendanaan bila donor berhenti	
Saldo kas saat ini	
Daya tahan kas (saldo kas ÷ kesenjangan), dalam bulan	
Target cadangan kas (3 × biaya tunai bulanan)	

Lampiran 8 Petunjuk Simulator Keberlanjutan CBC

Simulator Keberlanjutan CBC adalah lembar kerja Excel untuk menghitung biaya, pendapatan, dan proyeksi keberlanjutan klinik. Versi daringnya tersedia di e-learning. Tabel berikut merangkum fungsi setiap lembar.

Lembar	Isi	Kaitan dengan pedoman
0 Identitas	Data dasar klinik dan pengisi	Bab 2
1 Isian Klinik	Profil layanan, komposisi pengguna, batas tarif dan porsi pengguna yang mampu membayar	Bab 2, 8
2 Biaya	Biaya tetap dan variabel, termasuk yang dibayar donor dan nilai in-kind	Bab 5.2–5.3
3 Volume Layanan	Volume per jenis layanan	Bab 5.3
4 Data 12 Bulan	Data bulanan biaya, pendapatan, dan volume selama setahun	Bab 5.4–5.5
5 Kontrak dan Hibah	Kontrak dan hibah aktif beserta jangka waktunya	Bab 6, 7
6 Skenario	Proyeksi 36 bulan dengan beberapa skenario pembiayaan	Bab 5.5, 9
9 Cek Kesiapan	Versi ringkas cek kesiapan dari alat swa-nilai	Bab 2
Dasbor	Ringkasan angka kunci dan penjelasan "Apa artinya?"	Semua bab

Tips pengisian

- Isi bersama bagian keuangan dan pengelola layanan agar angka biaya dan volume konsisten.
- Beri label mutu pada setiap angka: A untuk data dari dokumen, B untuk estimasi pengelola, C untuk asumsi.
- Mulailah dari lembar 2 dan 3; lembar lain akan lebih mudah setelah biaya dan volume terisi.

Lampiran 9 Matriks Pemilihan Sumber Pembiayaan

Beri skor 1 (rendah) sampai 3 (tinggi) untuk setiap kriteria. Untuk "Risiko terhadap akses" dan "Biaya administrasi", skor 3 berarti risikonya atau bebannya rendah. Prioritaskan sumber dengan skor total tertinggi yang syaratnya dapat dipenuhi dalam 12 bulan.

Sumber	Prediktabilitas	Skala	Kecocokan misi	Biaya administrasi	Risiko akses	Keberlanjutan	Total	Syarat terpenuhi dalam 12 bulan?
JKN kapitasi								☐ Ya ☐ Tidak
JKN non-kapitasi								☐ Ya ☐ Tidak
Komoditas program								☐ Ya ☐ Tidak
APBD/SPM								☐ Ya ☐ Tidak
Swakelola tipe III								☐ Ya ☐ Tidak
Hibah daerah								☐ Ya ☐ Tidak
Pendapatan layanan								☐ Ya ☐ Tidak
CSR								☐ Ya ☐ Tidak
Zakat								☐ Ya ☐ Tidak
Filantropi								☐ Ya ☐ Tidak
Donor								☐ Ya ☐ Tidak

Lampiran 10 Templat Proposal ke CSR atau Filantropi

Proposal yang baik singkat, spesifik, dan menunjukkan dampak yang dapat diukur. Batasi pada 5–8 halaman.

Bagian	Isi	Tips
1. Ringkasan	Masalah, solusi, dana yang diminta, dampak yang diharapkan	Tulis terakhir; maksimal setengah halaman
2. Tentang klinik	Badan hukum, izin, layanan, capaian utama	Sertakan angka layanan dari SIHA
3. Masalah	Kebutuhan yang belum terpenuhi di wilayah	Gunakan data Dinas Kesehatan; hindari bahasa yang menstigma
4. Kegiatan yang diusulkan	Apa yang dibiayai, untuk siapa, berapa lama	Pilih kegiatan yang tidak dibiayai JKN atau APBD
5. Anggaran	Rincian biaya berdasarkan costing (Bab 5)	Tunjukkan kontribusi klinik dan sumber lain
6. Dampak dan pemantauan	Indikator, target, cara melapor	Sesuaikan dengan kepentingan mitra
7. Keberlanjutan	Apa yang terjadi setelah dukungan berakhir	Kaitkan dengan rencana transisi (Bab 9)
8. Tata kelola dan akuntabilitas	Struktur, audit, kebijakan kerahasiaan	Lampirkan laporan audit terakhir
9. Pengakuan bagi mitra	Cara mitra disebut atau ditampilkan	Pastikan tidak membuka identitas pengguna

Lampiran 11 Daftar Periksa Kredensialing BPJS Kesehatan

Konfirmasikan daftar dokumen terbaru dengan kantor cabang BPJS Kesehatan sebelum mengajukan permohonan.

	Butir	Keterangan
A. Kelayakan dasar		
☐	Izin klinik pratama yang masih berlaku	Klinik utama: lihat pilihan di Bab 3.3
☐	Konsultasi awal dengan BPJS Kesehatan cabang dan Dinas Kesehatan	Catat jadwal penerimaan dan kebutuhan FKTP di wilayah
B. Dokumen administrasi		
☐	NPWP badan hukum	
☐	STR dan SIP seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan	Pastikan SIP berlaku di klinik ini
☐	Surat penetapan dokter penanggung jawab	
☐	Perjanjian kerja sama dengan laboratorium jejaring	Bila laboratorium tidak tersedia di klinik
☐	Perjanjian kerja sama dengan apotek jejaring	Bila ruang farmasi tidak tersedia
☐	Perjanjian rujukan dengan rumah sakit	
☐	Status akreditasi atau rencana akreditasi	
C. Sarana dan sistem		
☐	Ruang pendaftaran, tunggu, periksa, dan administrasi sesuai standar	
☐	Peralatan medis dasar	
☐	Komputer, internet stabil, dan kesiapan memakai aplikasi BPJS	
☐	RME terhubung SATUSEHAT	
D. Komitmen layanan		
☐	Jadwal layanan tertulis, termasuk jam sore atau malam	
☐	Rencana menarik peserta dari komunitas dan masyarakat sekitar	
☐	Kebijakan kerahasiaan data pengguna	
E. Setelah lulus		
☐	Membaca dan memahami PKS, termasuk ketentuan kapitasi berbasis kinerja dan sanksi	
☐	Menyiapkan sistem pencatatan klaim non-kapitasi	
☐	Memperbarui matriks siapa membiayai apa (Bab 5) untuk mencegah pembiayaan ganda	

Lampiran 12 Daftar Periksa Swakelola Tipe III dan Kalender Anggaran

A. Kesiapan organisasi

	Butir	Keterangan
☐	Akta pendirian dan pengesahan badan hukum yayasan atau perkumpulan	
☐	Anggaran dasar memuat bidang kesehatan atau penanggulangan HIV	
☐	Susunan pengurus yang berlaku	
☐	NPWP organisasi dan rekening atas nama organisasi	
☐	Profil organisasi dan bukti pengalaman, misalnya laporan program tiga tahun terakhir	
☐	Laporan keuangan atau laporan audit terakhir	
☐	Perhitungan biaya per kegiatan (Bab 5)	Dasar rencana anggaran biaya
☐	Data kinerja layanan dari SIHA dan pencatatan klinik	Dasar usulan sasaran

B. Kalender kerja CBC

Bulan	Kegiatan CBC	Selesai
Januari–Maret	Ikut musrenbang; kirim usulan kegiatan dan data kebutuhan ke Dinkes	☐
Maret–Juni	Pastikan kegiatan masuk rencana kerja Dinkes; ajukan proposal hibah bila relevan	☐
Juli–Agustus	Advokasi bersama jaringan komunitas pada tahap kebijakan umum dan plafon anggaran	☐
September–November	Siapkan kerangka acuan dan rencana biaya rinci; pantau pembahasan APBD	☐
Desember–Januari	Pantau rencana umum pengadaan; siapkan dokumen penilaian kemampuan	☐
Sepanjang tahun anggaran	Laksanakan kegiatan; laporkan kemajuan dan penyerapan; siapkan pertanggungjawaban	☐

Lampiran 13 Templat Kerangka Acuan Kerja Swakelola

Kerangka acuan kerja (KAK) disusun perangkat daerah, tetapi CBC dapat menyiapkan rancangannya sebagai bahan usulan. Sesuaikan dengan model dokumen yang dipakai daerah.

Bagian	Isi	Contoh untuk layanan penjangkauan dan pendampingan
1. Latar belakang	Masalah dan dasar hukum	Capaian SPM pelayanan orang dengan risiko HIV; kesenjangan penemuan kasus pada populasi kunci
2. Maksud dan tujuan	Hasil yang diharapkan	Meningkatkan jumlah populasi kunci yang dites dan yang mulai ARV
3. Sasaran	Kelompok dan jumlah	Contoh: 1.200 orang dijangkau; 600 dites; 150 ODHIV didampingi
4. Ruang lingkup kegiatan	Rincian kegiatan	Penjangkauan, edukasi, rujukan tes, pendampingan ARV, pelacakan putus berobat
5. Keluaran	Produk yang diserahkan	Laporan bulanan agregat, laporan akhir
6. Indikator dan cara verifikasi	Ukuran keberhasilan	Jumlah dites tercatat di SIHA; persentase ODHIV didampingi yang tetap berobat
7. Jadwal	Waktu pelaksanaan	Februari–November
8. Organisasi pelaksana dan tim	Struktur tim pelaksana	Koordinator, pendamping sebaya, petugas administrasi
9. Rencana anggaran biaya	Rincian biaya berbasis costing	Honor pendamping sesuai porsi waktu, transportasi, komunikasi, bahan edukasi
10. Pelaporan dan kerahasiaan	Format laporan; pelindungan data	Laporan agregat tanpa identitas pengguna

Lampiran 14 Matriks Guardrail Akses dan Tarif

Gunakan matriks ini sebelum memberlakukan tarif baru atau mengubah model layanan. Setiap jawaban "Tidak" harus diperbaiki sebelum perubahan diberlakukan.

No	Pertanyaan uji	Ya	Tidak	Catatan perbaikan
1	Layanan inti HIV (tes dan konseling, ARV, pendampingan) tetap tanpa biaya bagi pengguna tidak mampu?	☐	☐	
2	Tidak ada pengguna yang akan ditolak karena tidak mampu membayar, tidak memiliki JKN, atau tidak membawa dokumen?	☐	☐	
3	Kriteria keringanan sederhana, tertutup, dan tidak mewajibkan surat keterangan tidak mampu untuk memulai layanan?	☐	☐	
4	Besaran tarif sudah dibahas dengan perwakilan komunitas dan diumumkan terbuka?	☐	☐	
5	Indikator pemantauan dan ambang peninjauan ulang sudah ditetapkan?	☐	☐	
6	Pengguna diberi tahu minimal satu bulan sebelum perubahan, melalui saluran yang aman?	☐	☐	
7	Tidak ada komponen yang dibiayai program atau sumber lain yang ikut ditagihkan kepada pengguna?	☐	☐	
8	Dampak perubahan terhadap kelompok yang paling rentan sudah dibahas, misalnya waria, penasun, dan pengguna tanpa JKN?	☐	☐	

Lampiran 15 Contoh Pesan Komunikasi Perubahan

Sesuaikan isi dengan perubahan yang terjadi di klinik Anda. Contoh berikut untuk pesan pribadi yang disampaikan pendamping sebaya.

Contoh 1: klinik mulai bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

Halo, kami ingin berbagi kabar. Mulai bulan depan, klinik kita bisa melayani dengan BPJS Kesehatan. Bagi yang sudah punya BPJS, kamu bisa memilih klinik ini sebagai faskes pertama. Kalau mau, kami bantu caranya. Yang tidak berubah: layanan tes dan obat ARV tetap seperti biasa, dan semua data kamu tetap rahasia. Kalau belum punya BPJS, layanan tetap bisa diterima. Ada pertanyaan? Hubungi kami kapan saja.

Contoh 2: klinik memberlakukan biaya untuk layanan tertentu

Halo, ada perubahan kecil di klinik mulai tanggal [tanggal]. Karena dukungan dana program berkurang, klinik mulai menarik biaya untuk [layanan tertentu] sebesar [tarif]. Yang tetap tanpa biaya: tes HIV, obat ARV, dan pendampingan. Kalau kamu sedang kesulitan biaya, sampaikan saja ke pendamping. Tidak perlu surat apa pun, dan kamu tidak akan ditolak. Perubahan ini terjadi karena kebijakan pendanaan, dan klinik tetap berkomitmen untuk melayani kita semua.

Contoh 3: layanan ARV lanjutan dialihkan ke puskesmas

Halo, kami ingin membicarakan pilihan baru untuk pengambilan obat ARV kamu. Puskesmas [nama] sekarang juga bisa melayani pengambilan ARV dan petugasnya sudah dilatih. Kalau kamu mau, kami bantu proses rujukannya dan pendamping tetap menemani. Kalau kamu lebih nyaman tetap di klinik, silakan sampaikan. Mari kita bicarakan pilihan yang paling cocok untukmu.

Lampiran 16 Kerangka Pemantauan Berbasis Komunitas

Pemantauan berbasis komunitas dijalankan oleh perwakilan komunitas yang bukan staf klinik, agar pengguna merasa aman menyampaikan pengalamannya.

Komponen	Isi
Pemantau	2–4 perwakilan komunitas yang dilatih; bukan staf klinik
Aspek yang dipantau	Ketersediaan obat dan reagen; waktu tunggu; biaya yang dibayar pengguna; sikap petugas; kerahasiaan; kemudahan layanan JKN; pengguna yang berhenti datang
Cara mengumpulkan data	Survei singkat anonim setiap bulan atau triwulan; diskusi kelompok kecil; catatan pengaduan
Ambang tindakan	Disepakati bersama klinik, misalnya bila lebih dari 10% responden melaporkan biaya sebagai hambatan
Pembahasan	Pertemuan triwulanan antara pemantau dan pimpinan klinik; hasil dan tindak lanjut dicatat
Tindak lanjut	Rencana perbaikan dengan penanggung jawab dan tenggat; dipantau pada pertemuan berikutnya
Pelaporan	Ringkasan agregat kepada badan pengawas klinik, Dinkes, dan pemberi kontrak bila disepakati
Pembiayaan	Dimasukkan ke anggaran klinik atau kontrak swakelola

Lampiran 17 Templat Rencana Transisi Klinik

Isi setiap bagian secara ringkas. Rencana disetujui badan pengawas dan dibahas dengan perwakilan komunitas.

Bagian	Isian
1. Ringkasan dan tujuan	Kondisi klinik yang ingin dicapai pada [bulan/tahun]:
2. Situasi awal	Tipe klinik: Kesiapan kelembagaan / finansial: Biaya tunai bulanan: Pendapatan non-donor bulanan: Kesenjangan pendanaan: Daya tahan kas:
3. Klasifikasi fungsi	Lampirkan Lampiran 18
4. Jalur transformasi	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 Alasan:
5. Target pembiayaan	Isi tabel A di bawah
6. Rencana aksi	Isi tabel B di bawah
7. Akses dan komunikasi	Hasil uji guardrail (Lampiran 14): Rencana komunikasi kepada pengguna: Peran komunitas:
8. Risiko dan mitigasi	Isi tabel C di bawah
9. Pemantauan	Indikator utama (Lampiran 20), jadwal tinjauan, penanggung jawab:
Persetujuan	Badan pengawas: _____ *Perwakilan komunitas:* ____ *Tanggal:*

A. Target pembiayaan per sumber

Sumber	Saat ini	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Donor				
JKN				
APBD (swakelola, hibah)				
Pendapatan layanan				
Filantropi, CSR, zakat				
Lainnya				
Total				

B. Rencana aksi

Kegiatan	Tonggak	Penanggung jawab	Tenggat	Anggaran	Status

Kegiatan	Tonggak	Penanggung jawab	Tenggat	Anggaran	Status

C. Risiko dan mitigasi

Risiko	Kemungkinan (R/S/T)	Dampak (R/S/T)	Mitigasi	Penanggung jawab

Lampiran 18 Lembar Klasifikasi Fungsi yang Bergantung pada Donor

Isi satu baris untuk setiap fungsi. Kekritisan: K = kritis, P = penting, D = pendukung.

Fungsi	Sumber dana saat ini	Biaya per bulan	Kekritisan	Arah	Sumber atau cara pengganti	Uji guardrail
Pendampingan ODHIV baru	*Donor 100%*	*Rp9.000.000*	*K*	*Pertahankan*	*Kontrak swakelola*	*Lolos*
				☐ Pertahankan ☐ Integrasikan ☐ Efisienkan ☐ Hentikan		☐ Lolos
				☐ Pertahankan ☐ Integrasikan ☐ Efisienkan ☐ Hentikan		☐ Lolos
				☐ Pertahankan ☐ Integrasikan ☐ Efisienkan ☐ Hentikan		☐ Lolos
				☐ Pertahankan ☐ Integrasikan ☐ Efisienkan ☐ Hentikan		☐ Lolos
				☐ Pertahankan ☐ Integrasikan ☐ Efisienkan ☐ Hentikan		☐ Lolos
				☐ Pertahankan ☐ Integrasikan ☐ Efisienkan ☐ Hentikan		☐ Lolos
				☐ Pertahankan ☐ Integrasikan ☐ Efisienkan ☐ Hentikan		☐ Lolos

Lampiran 19 Contoh Rencana Transisi (Klinik Fiktif)

Contoh ini menggambarkan klinik fiktif bertipe 2 yang disusun dari pola umum tujuh CBC. Contoh ini tidak menggambarkan klinik tertentu.

Bagian	Isi
Ringkasan	Klinik pratama milik yayasan komunitas di kota besar, mendampingi sekitar 450 ODHIV on ARV. Tujuan: pada akhir tahun ketiga, minimal 90% biaya tunai dibiayai sumber non-donor tanpa menurunkan kunjungan populasi kunci.
Situasi awal	Tipe 2; kesiapan kelembagaan mapan (3,0), finansial mapan (2,7); biaya tunai Rp64 juta per bulan; pendapatan non-donor Rp8 juta; daya tahan kas 1,6 bulan; belum bekerja sama dengan BPJS.
Klasifikasi fungsi	Pertahankan: pendampingan sebaya, jam layanan malam. Integrasikan: layanan klinis peserta JKN, pelaporan melalui RME. Efisienkan: administrasi digabung dengan program yayasan, sewa dinegosiasikan ulang. Hentikan: kegiatan edukasi umum yang tumpang tindih dengan puskesmas.
Jalur	Jalur 1 (FKTP JKN) dan jalur 4 (layanan umum untuk subsidi silang).
Target pembiayaan	Lihat Contoh 9.1: porsi donor 70% → 40% → 5%.
Rencana aksi utama	Konsultasi BPJS dan Dinkes (bulan 1); akreditasi (bulan 3–10); usulan musrenbang (bulan 2–3); kredensialing (bulan 10–12); kontrak swakelola penjangkauan (bulan 14); kampanye peserta JKN (bulan 12–24); pemindahan bertahap honor staf kunci (bulan 12–30).
Akses dan komunikasi	Tes, ARV, dan pendampingan tetap tanpa biaya; tarif hanya untuk layanan umum dengan keringanan tertutup; komunikasi melalui pendamping sebaya satu bulan sebelum setiap perubahan; pemantauan berbasis komunitas triwulanan.
Risiko utama	Kredensialing tertunda (mitigasi: kontrak swakelola didahulukan); dana daerah terlambat (mitigasi: cadangan kas dibangun dari tahun kedua).
Pemantauan	Dasbor bulanan; tinjauan triwulanan bersama komunitas; revisi rencana setiap enam bulan.

Lampiran 20 Dasbor Indikator Keberlanjutan

Isi setiap bulan. Beri tanda status: ● hijau (sesuai target), ● kuning (perlu perhatian), ● merah (perlu tindakan).

Indikator	Target	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Status	Tindak lanjut
Porsi pendapatan non-donor						
Daya tahan kas (bulan)						
Cadangan kas (bulan)						
Peserta JKN terdaftar						
Hari kekosongan stok						
Staf kunci dengan honor stabil						
Ketepatan pelaporan SIHA						
Kunjungan populasi kunci						
ODHIV yang tetap berobat						
Pengaduan ditindaklanjuti						

Lampiran 21 Ringkasan Profil Anonim CBC A–G

Profil berikut disusun dari self-assessment Oktober 2026. Domain terkuat dan terlemah dihitung dari domain A–H. Prioritas adalah usulan awal yang akan dikonfirmasi bersama klinik.

Klinik	Tipe	Kelembagaan	Finansial	Domain terkuat	Domain terlemah	Prioritas awal
CBC A	1	Mapan (3,21)	Mapan (3,20)	E Sistem informasi	B Perencanaan; D SDM	Optimalkan JKN; rencana transisi tertulis
CBC B	4	Mapan (2,64)	Mapan (2,60)	A Tata kelola	H Perizinan	Pilih jalur: jejaring dengan kontrak atau klinik pratama
CBC C	2	Mapan (3,09)	Mapan (2,60)	G Kemitraan	B Perencanaan	Penyesuaian izin klinik utama; kredensialing
CBC D	3	Berkembang (2,33)	Merintis (1,24)	A Tata kelola	C Keuangan	Costing dan arus kas; fungsi prioritas; dana daerah
CBC E	2	Mapan (2,85)	Maju (3,40)	A Tata kelola	H Perizinan	Penyesuaian izin klinik utama; retensi SDM
CBC F	2	Maju (3,28)	Maju (3,27)	E Sistem informasi	H Perizinan	Kredensialing JKN; swakelola
CBC G	3	Mapan (2,71)	Berkembang (2,20)	A, E, F, G (setara)	H Perizinan	Diversifikasi; advokasi anggaran; usaha sosial

Sumber: self-assessment kapasitas klinik, 23 responden dari 7 CBC, Oktober 2026 (data tidak dipublikasikan).

Daftar Istilah

Istilah	Pengertian
Biaya penuh	Biaya tunai ditambah nilai in-kind.
Biaya tetap	Biaya yang tidak berubah meskipun jumlah kunjungan naik atau turun dalam rentang tertentu.
Biaya tunai	Biaya yang benar-benar dibayar klinik atau donornya.
Biaya variabel	Biaya yang bertambah setiap ada kunjungan atau layanan.
CBC (Community-Based Clinic)	Klinik berizin yang layanannya ditujukan terutama bagi ODHIV, populasi kunci, dan komunitas rentan, dengan keterlibatan komunitas yang bermakna (lihat 2.1).
Community-led	Organisasi atau layanan yang sebagian besar tata kelola, kepemimpinan, staf, dan relawannya berasal dari dan bertanggung jawab kepada komunitas yang dilayani.
Daya tahan kas	Saldo kas dibagi kesenjangan pendanaan bulanan; menunjukkan berapa bulan klinik dapat bertahan.
FKRTL	Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, misalnya rumah sakit dan klinik utama, yang menerima pasien JKN berdasarkan rujukan.
FKTP	Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan nonspesialistik bagi peserta JKN.
Guardrail akses	Batas yang tidak boleh dilanggar oleh keputusan pembiayaan agar akses kelompok rentan tetap terjaga (lihat Bab 8).
Hibah daerah	Pemberian dana dari pemerintah daerah kepada organisasi masyarakat untuk kegiatan yang mendukung urusan pemerintahan daerah, berdasarkan naskah perjanjian hibah.
In-kind	Dukungan berupa barang atau jasa, bukan uang, misalnya komoditas program, staf yang dibayar pihak lain, atau ruang pinjaman.
Istilah	Pengertian
Jalur transformasi	Pilihan perubahan model klinik untuk mencapai keberlanjutan (lihat Bab 9.3).
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
KAK	Kerangka acuan kerja; dokumen yang menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, kegiatan, keluaran, jadwal, dan biaya suatu pekerjaan.
Kapitasi	Pembayaran bulanan dari BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta terdaftar, tanpa memperhitungkan jumlah layanan yang diberikan.
Kapitasi berbasis kinerja	Penyesuaian pembayaran kapitasi berdasarkan capaian indikator kinerja FKTP.
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; kode kegiatan usaha yang dipilih saat mengurus NIB.
Kebutuhan dana minimum	Biaya untuk fungsi berarah "pertahankan" dan "integrasikan" selama masa peralihan; batas bawah yang harus diamankan.
Kesenjangan pendanaan	Selisih antara biaya tunai dan pendapatan yang tetap ada setelah dukungan donor berakhir.
Kesiapan finansial	Skor domain C pada alat swa-nilai.
Kesiapan kelembagaan	Rata-rata skor domain A, B, D, E, F, G, dan H pada alat swa-nilai.

Istilah	Pengertian
KKPR	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; persyaratan dasar bahwa lokasi usaha sesuai rencana tata ruang.
Klinik pratama	Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar; dalam JKN berposisi sebagai FKTP.
Klinik utama	Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau gabungan dasar dan spesialistik; dalam JKN berposisi sebagai FKRTL.
Kontrak sosial	Mekanisme pemerintah membiayai organisasi masyarakat untuk memberikan layanan, misalnya melalui swakelola tipe III.
Kredensialing	Proses penilaian kelayakan fasilitas kesehatan oleh BPJS Kesehatan sebelum perjanjian kerja sama.
Musrenbang	Musyawarah perencanaan pembangunan; forum penyusunan usulan rencana pembangunan daerah.
NIB	Nomor Induk Berusaha; identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui OSS.
Non-kapitasi	Pembayaran BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan layanan tertentu yang diberikan.
ODHIV	Orang dengan HIV.
OSS	Online Single Submission; sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik.
PBG dan SLF	Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi; persyaratan dasar bangunan.
Pemantauan berbasis komunitas	Pemantauan mutu dan akses layanan yang dilakukan oleh komunitas pengguna secara rutin dan ditindaklanjuti bersama penyedia layanan.
Pembiayaan ganda	Satu layanan atau komponen biaya yang dibiayai lebih dari satu sumber, misalnya dibiayai donor sekaligus diklaim ke JKN.
Peserta terdaftar	Peserta JKN yang memilih suatu FKTP sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertamanya; dasar perhitungan kapitasi.
PKS	Perjanjian kerja sama, misalnya antara klinik dan BPJS Kesehatan.
Populasi kunci	Kelompok dengan risiko tinggi terhadap HIV, antara lain lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), waria atau transpuan, pekerja seks, dan pengguna napza suntik.
Rencana transisi	Rencana bertahap untuk mengalihkan pembiayaan dan pengelolaan fungsi klinik dari dukungan donor ke sumber domestik tanpa menurunkan akses.
RME	Rekam medis elektronik.
SATUSEHAT	Platform integrasi data kesehatan nasional milik Kementerian Kesehatan.
SIHA	Sistem Informasi HIV, AIDS, dan IMS milik Kementerian Kesehatan.
SPM	Standar Pelayanan Minimal; layanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.
Staf kunci	Staf yang bila keluar akan menghentikan atau mengganggu layanan secara berarti.
STR dan SIP	Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Subsidi silang	Penggunaan pendapatan dari layanan bagi yang mampu untuk membiayai layanan bagi yang tidak mampu.
Swakelola tipe III	Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan berdasarkan kontrak dengan pejabat pembuat komitmen.

Istilah	Pengertian
Tipe klinik	Pengelompokan CBC berdasarkan izin, kesiapan finansial, dan keterhubungan dengan dana publik (lihat 2.6).
Titik impas	Volume layanan atau jumlah peserta yang membuat pendapatan sama dengan biaya.
Transisi	Proses peralihan pembiayaan dan pengelolaan layanan dari dukungan donor ke sumber domestik.

Daftar Pustaka

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berani tes, berani lindungi diri: Kemenkes targetkan eliminasi HIV dan IMS tahun 2030 [Internet]. Jakarta: Kemenkes; 2025 Jun 21 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://kemkes.go.id/id/berani-tes-berani-lindungi-diri-kemenkes-targetkan-eliminasi-hiv-dan-ims-tahun-2030
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831. Jakarta: Kemenkes; 2022.
3. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Global AIDS Strategy 2026–2031: united towards ending AIDS. UNAIDS/PCB(57)/25. Geneva: UNAIDS; 2025 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://www.unaids.org/sites/default/files/2025-11/PCB57_Global_AIDS_Strategy_2026-2031_0.pdf
4. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Transition timelines, April 2026. Geneva: Global Fund; 2026 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://resources.theglobalfund.org/media/hvkncr4j/cr_gc8-transition-timelines_list_en.pdf
5. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Sustainable transition: advancing a managed path to domestic financing in Indonesia [Internet]. Geneva: Global Fund; 2026 Sep 16 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://www.theglobalfund.org/en/stories/2026/2026-09-16-sustainable-transition-managed-path-domestic-financing-indonesia/
6. World Health Organization Indonesia. Bridging service gaps through Indonesia's HIV Joint Programme Review [Internet]. Jakarta: WHO; 2026 Apr 30 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-04-2026-bridging-service-gaps-through-indonesia-s-hiv-joint-programme-review
7. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. UNAIDS Programme Coordinating Board adopts new Global AIDS Strategy [Internet]. Geneva: UNAIDS; 2025 Des 19 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2025/december/20251219_pcb57
8. World Health Organization. Sustaining priority services for HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections in a changing funding landscape: operational guidance. Geneva: WHO; 2025 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://reliefweb.int/report/world/sustaining-priority-services-hiv-viral-hepatitis-and-sexually-transmitted-infections-changing-funding-landscape-operational-guidance
9. World Health Organization. Consolidated HIV guidelines: service delivery. Geneva: WHO; 2026 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://www.who.int/publications/i/item/9789240124233
10. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Jakarta: Sekretariat Negara; 2022.
11. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Jakarta: Sekretariat Negara; 2023.
12. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135. Jakarta: Sekretariat Negara; 2024.
13. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Jakarta: Sekretariat Negara; 2018, 2024.
14. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara; 2025.
15. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kemenkes; 2022.

16. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 173. Jakarta: Kemenkes; 2026.
17. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Community-led AIDS responses: final report based on the recommendations of the multistakeholder task team. Geneva: UNAIDS; 2022.
18. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Global AIDS Strategy 2021–2026. End inequalities. End AIDS. Geneva: UNAIDS; 2021.
19. World Health Organization. Consolidated guidelines on HIV, viral hepatitis and STI prevention, diagnosis, treatment and care for key populations. Geneva: WHO; 2022.
20. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Diseminasi juklak layanan HIV/AIDS dan IMS dalam skema JKN [Internet]. Jakarta: Kemenkes; 2022 Des 22 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/diseminasi-juklak-layanan-hiv-aids-dan-ims-dalam-skema-jkn
21. World Health Organization. Everybody’s business: strengthening health systems to improve health outcomes. WHO’s framework for action. Geneva: WHO; 2007.
22. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Technical brief: transition and co-financing. Grant Cycle 8 core guidance. Geneva: Global Fund; 2026 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://resources.theglobalfund.org/media/3z0njdq2/cr_gc8-transition-and-cofinancing_technical-brief_en.pdf
23. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Jakarta: Sekretariat Negara; 2013, 2017.
24. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Jakarta: Sekretariat Negara; 2001, 2004.
25. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. Jakarta: Kemenkes; 2025.
26. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400. Jakarta: Kemenkes; 2013.
27. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Sekretariat Negara; 2025.
28. IzinBeres. Izin klinik dan apotek 2026: Permenkes 11/2025 cabut aturan lama [Internet]. 2026 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://www.izinberes.com/blog/izin-klinik-apotek-permenkes-11-2025.html
29. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Jakarta: Kemenkes; 2022.
30. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Jakarta: Kemenkes; 2024.
31. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara; 2019.
32. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Sekretariat Negara; 2007.
33. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Sekretariat Negara; 2011.

34. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Jakarta: Kemenkes; 2023.
35. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini dia standar tarif baru pelayanan JKN [Internet]. Jakarta: Kemenkes; 2023 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://www.kemkes.go.id/id/ini-dia-standar-tarif-baru-pelayanan-jkn
36. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Kemenkes; 2015.
37. Medisy. Panduan lengkap kredensialing FKTP: cara mendaftarkan klinik dan dokter menjadi mitra BPJS [Internet]. [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://medisy.id/article/panduan-lengkap-kredensialing-fktp-cara-mendaftarkan-klinik-dokter-menjadi-mitra-bpjs
38. Detik Health. Penjelasan BPJS Kesehatan soal pindah faskes harus menunggu 3 bulan [Internet]. Jakarta: Detik; 2026 Agu 2 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8600280/penjelasan-bpjs-kesehatan-soal-pindah-faskes-harus-menunggu-3-bulan
39. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola. Jakarta: LKPP; 2021.
40. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kemendagri; 2020.
41. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Progress update on sustainability in the HIV response. UNAIDS/PCB(57)/25.29. Geneva: UNAIDS; 2025 [diakses 1 Nov 2026]. Tersedia dari: https://www.unaids.org/sites/default/files/2025-11/PCB57_Sustainability_Update_EN.pdf